

Buku Referensi

KEPERAWATAN PALIATIF

Asuhan Komprehensif, Kontrol Gejala, dan Dukungan Keluarga
pada Penyakit Mengancam Nyawa

Bernadetta Germia Aridamayanti • Siti Rachmah
Masyita Haerianti • Nadia Alfira



BUKU REFERENSI KEPERAWATAN PALIATIF: ASUHAN KOMPREHENSIF, KONTROL GEJALA, DAN DUKUNGAN KELUARGA PADA PENYAKIT MENGANCAM NYAWA

Penulis:

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Siti Rachmah, SKM., M.Kes.

Masyita Haerianti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Nadia Alfira, S.Kep., Ns., M.Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi Keperawatan Paliatif: Asuhan Komprehensif, Kontrol Gejala, dan Dukungan Keluarga pada Penyakit Mengancam Nyawa

Penulis:

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Siti Rachmah, SKM., M.Kes.

Masyita Haerianti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Nadia Alfira, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-03-9

Cetakan Pertama : Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga buku referensi yang berjudul Keperawatan Paliatif: Asuhan Komprehensif, Kontrol Gejala, dan Dukungan Keluarga pada Penyakit Mengancam Nyawa ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu kontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya pada bidang keperawatan paliatif yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga.

Keperawatan paliatif merupakan pendekatan pelayanan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien dengan penyakit mengancam nyawa, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, spiritual, maupun emosional. Pelayanan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi keluhan atau gejala yang dialami pasien, tetapi juga memberikan dukungan menyeluruh agar pasien dapat menjalani kehidupannya dengan lebih nyaman, bermakna, dan bermartabat.

Buku referensi ini membahas berbagai konsep penting dalam keperawatan paliatif, mulai dari prinsip dasar asuhan paliatif, pengkajian kebutuhan pasien, kontrol gejala, manajemen nyeri, komunikasi terapeutik, dukungan psikososial dan spiritual, hingga peran keluarga dalam proses perawatan. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya kerja sama antarprofesi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, humanis, dan berpusat pada pasien.

Dalam praktik keperawatan paliatif, perawat memiliki peran yang sangat strategis sebagai pemberi asuhan, pendamping, edukator, advokat, serta penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Oleh karena itu, perawat dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan klinis, empati, serta kepekaan dalam memahami kondisi pasien dan keluarga, terutama pada situasi yang penuh tantangan secara emosional.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pelayanan paliatif. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami pentingnya asuhan paliatif yang komprehensif, pengendalian gejala yang tepat, serta dukungan keluarga sebagai bagian integral dalam perawatan pasien dengan penyakit mengancam nyawa.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa yang

akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan kualitas pelayanan paliatif. Semoga buku ini juga dapat menjadi salah satu rujukan dalam membentuk perawat yang profesional, empatik, humanis, serta mampu memberikan asuhan yang bermartabat bagi pasien dan keluarga.

Penulis

Mei, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	v
------------------------	----------

BAB I PENGKAJIAN PALIATIF KOMPREHENSIF (FISIK, PSIKOLOGIS, SOSIAL, SPIRITUAL; KEBUTUHAN PASIEN-KELUARGA 1

A. Pendahuluan.....	1
B. Pengkajian Dimensi Fisik pada Pasien Paliatif.....	2
C. Pengkajian Dimensi Psikologis pada Pasien dengan Penyakit Mengancam Nyawa	4
D. Pengkajian Dimensi Sosial dan Dukungan Keluarga	6
E. Pengkajian Dimensi Spiritual dan Makna Hidup.....	8
F. Pengkajian Kebutuhan Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Paliatif.....	10
G. Penilaian Kualitas Hidup pada Pasien Paliatif.....	12
H. Penutup	14
Referensi.....	15

BAB II KONTROL GEJALA UTAMA 17

A. Pendahuluan.....	17
B. Kontrol Gejala Utama Dalam Perawatan Paliatif	17
C. Penutup	31
Referensi.....	32

BAB III KOMUNIKASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN (ADVANCE CARE PLANNING, GOALS OF CARE, INFORMED CONSENT DAN PENYAMPAIAN KABAR SULIT).....35

A. Pendahuluan.....	35
B. Advance Care Planning.....	35
C. Tujuan Advance Care Planning.....	36
D. Manfaat Advance Care Planning.....	36
E. Isi Advance Care Planning	37
F. Faktor Pelaksanaan Advance Care Planning	37
G. Cara Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Advance Care Planning	38
H. Strategi Efektif Pelaksanaan Advance Care Planning	38

I. Goals of Care	40
J. Informed Consent.....	41
K. Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk	41
L. Tujuan Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk.....	52
M.Siapa yang Seharusnya Menyampaikan Kabar Sulit atau Buruk.....	52
N. Faktor dalam Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk	53
O. Upaya dalam Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk.....	53
P. Do dan Don'ts dalam Menyampaikan Kabar Sulit atau Buruk	54
Q. Penutup	54
Referensi.....	55

BAB IV DUKUNGAN KELUARGA DAN BEREAVEMENT CARE (EDUKASI CAREGIVER, DUKUNGAN PSIKOSOSIAL, PENDAMPINGAN DUKA, DAN

RUJUKAN)	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Konsep dasar Keluarga dan Dukungan Keluarga dalam Perawatan	57
C. Konsep dan Peran Caregiver	59
D. Dukungan Psikososial bagi Keluarga dan Caregiver.....	62
E. Konsep dan Tahapan Bereavement (Kedukaan).....	64
F. Bereavement Care (Pendampingan Duka).....	67
G. Rujukan dan Sistem Dukungan Lanjutan	69
H. Tantangan dan Strategi Implementasi di Lapangan.....	70
I. Penutup	72
Referensi.....	73

PROFIL PENULIS	77
-----------------------------	-----------

BAB I

PENGKAJIAN PALIATIF KOMPREHENSIF (FISIK, PSIKOLOGIS, SOSIAL, SPIRITUAL; KEBUTUHAN PASIEN-KELUARGA)

A. Pendahuluan

Pengkajian dalam keperawatan paliatif merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien yang mengalami penyakit mengancam nyawa secara menyeluruh. Pengkajian paliatif tidak hanya berfokus pada kondisi klinis atau gejala fisik yang dialami pasien, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual yang memengaruhi kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Konsep pengkajian dalam konteks perawatan paliatif didasarkan pada pendekatan *holistic care*, yaitu suatu pendekatan yang memandang individu sebagai kesatuan utuh yang terdiri atas aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap pengalaman sakit yang dialami pasien, termasuk persepsi terhadap penyakit, nilai-nilai kehidupan, serta harapan yang dimiliki selama menjalani proses perawatan. Pengkajian paliatif bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasien sehingga tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat merencanakan intervensi yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup pasien meskipun berada dalam kondisi penyakit yang bersifat progresif atau terminal.

Tujuan utama pengkajian dalam keperawatan paliatif adalah mengidentifikasi berbagai masalah dan kebutuhan pasien yang muncul akibat penyakit yang diderita serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Pengkajian ini berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan klinis yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien. Prinsip dasar pengkajian paliatif meliputi pendekatan *patient-centered care* dan *family-centered care*, yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat dari proses perawatan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kebutuhan, nilai, keyakinan, serta preferensi pasien dan keluarga harus menjadi pertimbangan utama dalam proses pengkajian dan perencanaan asuhan. Karakteristik lain dari pengkajian paliatif adalah sifatnya yang berkelanjutan atau *continuous assessment*, karena kondisi pasien dengan penyakit

kronis progresif dapat berubah secara dinamis dari waktu ke waktu. Pendekatan *interdisciplinary care* juga menjadi bagian penting dalam pengkajian paliatif, karena kebutuhan pasien sering kali melibatkan berbagai aspek yang memerlukan kolaborasi antara perawat, dokter, psikolog, pekerja sosial, rohaniawan, serta tenaga kesehatan lainnya.

Peran perawat dalam proses pengkajian paliatif sangat strategis karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki intensitas kontak paling tinggi dengan pasien dan keluarga selama proses perawatan. Perawat bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian komprehensif yang mencakup identifikasi gejala fisik, kondisi emosional, situasi sosial, serta kebutuhan spiritual pasien. Kemampuan komunikasi terapeutik menjadi komponen penting dalam pengkajian tersebut, karena banyak informasi yang berkaitan dengan pengalaman sakit, ketakutan, maupun harapan pasien hanya dapat diperoleh melalui interaksi yang empatik dan penuh kepercayaan. Pengkajian dalam keperawatan paliatif memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pengkajian pada kondisi kuratif. Pendekatan kuratif umumnya berorientasi pada identifikasi masalah kesehatan yang dapat diatasi melalui terapi medis dengan tujuan utama mencapai kesembuhan penyakit. Pengkajian paliatif memiliki orientasi yang berbeda, yaitu menekankan upaya mengurangi penderitaan, mengendalikan gejala, serta mempertahankan martabat dan kualitas hidup pasien selama perjalanan penyakit. Perspektif tersebut menempatkan pengkajian sebagai fondasi penting dalam penyusunan rencana asuhan yang berfokus pada kenyamanan, dukungan emosional, serta pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarga secara menyeluruh.

B. Pengkajian Dimensi Fisik pada Pasien Paliatif

Pengkajian dimensi fisik pada pasien paliatif merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai perubahan kondisi tubuh akibat penyakit kronis progresif atau penyakit yang mengancam kehidupan. Proses pengkajian tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien, perjalanan penyakit, serta respons tubuh terhadap terapi yang sedang dijalani. Fokus utama pengkajian fisik mencakup identifikasi berbagai gejala yang sering muncul pada pasien paliatif, seperti nyeri, kelelahan, gangguan pernapasan, mual dan muntah, gangguan nutrisi, serta gangguan tidur. Nyeri sering menjadi keluhan dominan yang memengaruhi kenyamanan dan kualitas hidup pasien sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam mengenai lokasi, intensitas, durasi, karakteristik, serta faktor yang memperberat dan mengurangi nyeri. Kelelahan atau *fatigue* juga merupakan gejala yang umum dialami pasien dengan penyakit kronis progresif dan sering berdampak pada penurunan kemampuan

melakukan aktivitas sehari-hari. Pengkajian fisik juga perlu memperhatikan gangguan respirasi seperti sesak napas atau *dyspnea*, yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan signifikan dan kecemasan pada pasien (Dookie, 2025; Pastrana et al., 2025).

Proses pengkajian fisik pada pasien paliatif tidak hanya terbatas pada identifikasi gejala utama, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kondisi nutrisi, fungsi gastrointestinal, serta perubahan fungsi tubuh lainnya yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Gangguan nutrisi sering terjadi akibat penurunan nafsu makan, kesulitan menelan, perubahan metabolisme, atau efek samping pengobatan yang dijalani pasien (Dookie, 2025; Pastrana et al., 2025). Kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan otot, serta penurunan daya tahan tubuh yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Gangguan tidur juga merupakan masalah yang sering muncul pada pasien paliatif akibat nyeri, kecemasan, gangguan pernapasan, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Penilaian terhadap pola tidur, kualitas tidur, serta faktor yang memengaruhi gangguan tidur menjadi bagian penting dalam pengkajian fisik karena gangguan tidur dapat memperburuk kondisi fisik dan psikologis pasien. Perubahan fungsi tubuh lain seperti gangguan eliminasi, kelemahan fisik, serta penurunan mobilitas juga perlu dikaji secara komprehensif guna memahami kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh (Dookie, 2025; Pastrana et al., 2025).

Pengkajian dimensi fisik pada pasien paliatif memerlukan penggunaan instrumen penilaian gejala yang terstandar agar proses identifikasi kondisi pasien dapat dilakukan secara objektif dan sistematis. Berbagai instrumen telah dikembangkan untuk membantu tenaga kesehatan dalam menilai intensitas gejala dan dampaknya terhadap kehidupan pasien, seperti *Numerical Rating Scale*, *Visual Analog Scale*, serta *Edmonton Symptom Assessment System*. Penggunaan instrumen tersebut memungkinkan tenaga kesehatan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat keparahan gejala yang dialami pasien. Pemantauan perkembangan gejala secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam praktik keperawatan paliatif karena kondisi fisik pasien dapat berubah secara dinamis seiring dengan progresivitas penyakit (Nejatifar et al., 2025). Hasil pengkajian yang dilakukan secara periodik dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan intervensi keperawatan yang tepat serta mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diberikan. Pendekatan pengkajian yang komprehensif dan berkelanjutan memungkinkan perawat memberikan asuhan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien sehingga kenyamanan dan kualitas hidup pasien dapat tetap terjaga (Nejatifar et al., 2025; Pastrana et al., 2025).

Tabel 1.1 Contoh Komponen Pengkajian Dimensi Fisik pada Pasien Paliatif

Aspek yang Dikaji	Manifestasi Klinis yang Umum	Fokus Pengkajian Keperawatan	Contoh Instrumen
Nyeri	Nyeri kronis, nyeri lokal atau menyebar	Lokasi, intensitas, durasi, karakteristik, faktor pencetus	<i>Numerical Rating Scale, Visual Analog Scale</i>
Kelelahan	Lemas, penurunan energi, intoleransi aktivitas	Tingkat energi, kemampuan aktivitas sehari-hari	<i>Brief Fatigue Inventory</i>
Gangguan Pernapasan	Sesak napas, napas cepat, napas dangkal	Frekuensi napas, tingkat sesak, faktor pencetus	<i>Dyspnea Scale</i>
Gangguan Gastrointestinal	Mual, muntah, konstipasi, anoreksia	Frekuensi mual, muntah, pola makan, fungsi pencernaan	<i>Edmonton Symptom Assessment System</i>
Gangguan Nutrisi	Penurunan berat badan, penurunan nafsu makan	Status gizi, asupan makanan, kemampuan menelan	<i>Mini Nutritional Assessment</i>
Gangguan Tidur	Insomnia, sering terbangun, tidur tidak nyenyak	Durasi tidur, kualitas tidur, faktor pengganggu	<i>Pittsburgh Sleep Quality Index</i>
Perubahan Fungsi Fisik	Penurunan mobilitas, kelemahan otot	Kemampuan mobilisasi, kebutuhan bantuan aktivitas	<i>Karnofsky Performance Scale</i>

C. Pengkajian Dimensi Psikologis pada Pasien dengan Penyakit Mengancam Nyawa

Pengkajian dimensi fisik merupakan komponen fundamental dalam perawatan paliatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai gejala dan perubahan kondisi tubuh yang dialami pasien dengan penyakit mengancam nyawa. Proses pengkajian dilakukan secara sistematis dan komprehensif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai status kesehatan pasien serta dampak penyakit terhadap fungsi tubuh. Pasien dengan penyakit terminal atau kronis progresif sering mengalami berbagai keluhan fisik yang kompleks dan saling berkaitan, sehingga membutuhkan pendekatan pengkajian yang terstruktur dan berkelanjutan. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan observasi klinis, pengumpulan data

subjektif dan objektif, serta evaluasi respons pasien terhadap gejala yang muncul. Pendekatan ini berorientasi pada peningkatan kenyamanan pasien melalui prinsip *symptom management* dan *holistic care*, sehingga setiap perubahan kondisi fisik dapat diidentifikasi secara dini dan ditangani secara tepat (Pastrana et al., 2025).

Berbagai gejala fisik yang sering muncul pada pasien paliatif meliputi nyeri, kelelahan, gangguan pernapasan, mual dan muntah, gangguan nutrisi, gangguan tidur, serta penurunan fungsi tubuh secara umum. Nyeri merupakan salah satu keluhan yang paling sering dilaporkan oleh pasien dengan penyakit kronis progresif dan sering kali menjadi fokus utama dalam pengkajian fisik. Kondisi kelelahan yang berkepanjangan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup pasien. Gangguan pernapasan seperti sesak napas atau *dyspnea* juga sering terjadi pada pasien dengan penyakit paru, penyakit jantung, maupun kanker stadium lanjut. Keluhan lain seperti mual dan muntah dapat muncul akibat efek penyakit, terapi medis, maupun gangguan metabolik. Gangguan nutrisi sering ditandai dengan penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, serta kondisi *cachexia*. Gangguan tidur juga sering ditemukan pada pasien paliatif dan dapat berkaitan dengan nyeri, kecemasan, atau ketidaknyamanan fisik lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengkajian fisik tidak hanya berfokus pada satu gejala tertentu, melainkan mencakup keseluruhan respon tubuh terhadap proses penyakit (Nejatifar et al., 2025).

Pelaksanaan pengkajian dimensi fisik dalam perawatan paliatif memerlukan penggunaan instrumen penilaian gejala yang valid dan reliabel guna memperoleh data yang lebih objektif dan terukur. Berbagai instrumen yang sering digunakan dalam praktik paliatif antara lain *Numeric Rating Scale*, *Visual Analog Scale*, *Edmonton Symptom Assessment System*, serta *Palliative Performance Scale*. Instrumen tersebut membantu perawat dalam menilai intensitas gejala, memantau perkembangan kondisi pasien, serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Pemantauan gejala secara berkala menjadi aspek penting dalam praktik perawatan paliatif karena kondisi pasien dapat berubah secara dinamis seiring perkembangan penyakit. Pendokumentasian hasil pengkajian secara sistematis juga berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan klinis serta koordinasi antar anggota tim kesehatan. Pendekatan pengkajian yang berkesinambungan memungkinkan perawat untuk memberikan intervensi yang lebih tepat, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kenyamanan serta kualitas hidup pasien (Dookie, 2025).

Tabel 1.2 Gejala Fisik Umum pada Pasien Paliatif dan Aspek Pengkajiannya

No	Gejala Fisik	Deskripsi Gejala	Aspek yang Dikaji	Contoh Instrumen
1.	Nyeri	Sensasi tidak nyaman akibat kerusakan jaringan atau proses penyakit	Intensitas nyeri, lokasi, durasi, karakteristik nyeri, faktor pencetus dan pereda	<i>Numeric Rating Scale, Visual Analog Scale</i>
2.	Kelelahan	Kondisi lemah dan penurunan energi yang tidak membaik dengan istirahat	Tingkat energi, kemampuan melakukan aktivitas, durasi kelelahan	<i>Edmonton Symptom Assessment System</i>
3.	Gangguan Pernapasan	Kesulitan bernapas atau sensasi sesak	Frekuensi napas, kedalaman napas, penggunaan otot bantu napas, tingkat sesak	<i>Dyspnea Scale, Edmonton Symptom Assessment System</i>
4.	Mual dan Muntah	Sensasi ingin muntah yang dapat disertai pengeluaran isi lambung	Frekuensi mual, frekuensi muntah, pemicu, dampak terhadap makan	<i>Edmonton Symptom Assessment System</i>
5.	Gangguan Nutrisi	Penurunan nafsu makan dan perubahan status gizi	Nafsu makan, berat badan, asupan makanan, tanda malnutrisi	<i>Mini Nutritional Assessment</i>
6.	Gangguan Tidur	Kesulitan memulai atau mempertahankan tidur	Durasi tidur, kualitas tidur, frekuensi terbangun, faktor penyebab	<i>Pittsburgh Sleep Quality Index</i>
7.	Penurunan Fungsi Fisik	Penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari	Mobilitas, kemampuan perawatan diri, tingkat ketergantungan	<i>Palliative Performance Scale</i>

D. Pengkajian Dimensi Sosial dan Dukungan Keluarga

Pengkajian dimensi sosial merupakan komponen penting dalam asuhan keperawatan paliatif karena kondisi penyakit yang mengancam nyawa tidak hanya memengaruhi aspek fisik pasien, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial individu dan keluarganya. Pemahaman terhadap kondisi sosial pasien mencakup identifikasi struktur keluarga, hubungan interpersonal, peran sosial dalam

keluarga maupun masyarakat, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kemampuan pasien dalam mengakses layanan kesehatan. Informasi mengenai struktur keluarga memberikan gambaran mengenai anggota keluarga yang tinggal bersama pasien, pola pengambilan keputusan dalam keluarga, serta pihak yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses perawatan. Hubungan interpersonal yang terjalin antara pasien dan anggota keluarga juga menjadi aspek penting karena kualitas relasi tersebut dapat memengaruhi tingkat dukungan emosional yang diterima pasien selama menjalani proses perawatan paliatif. Pendekatan pengkajian sosial dalam konteks ini menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari sistem perawatan dengan prinsip *family-centered care*, yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif keluarga dalam proses pengambilan keputusan dan perawatan pasien (Dookie, 2025).

Identifikasi *caregiver* utama menjadi bagian krusial dalam pengkajian dimensi sosial karena individu tersebut memiliki peran dominan dalam memberikan bantuan sehari-hari kepada pasien. *Caregiver* utama biasanya merupakan anggota keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, maupun administratif pasien selama menjalani pengobatan. Peran ini sering kali disertai dengan beban psikologis, sosial, dan ekonomi yang cukup besar sehingga memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan. Dinamika keluarga dalam menghadapi penyakit juga perlu dikaji secara mendalam karena setiap keluarga memiliki mekanisme adaptasi yang berbeda dalam merespons kondisi penyakit yang progresif dan berpotensi mengancam kehidupan. Proses adaptasi tersebut dapat ditandai oleh perubahan peran dalam keluarga, munculnya konflik interpersonal, atau meningkatnya solidaritas keluarga dalam memberikan dukungan kepada pasien. Pemahaman terhadap dinamika keluarga membantu perawat dalam merancang intervensi yang lebih sensitif terhadap kebutuhan sosial pasien dan keluarganya serta memperkuat sistem dukungan yang tersedia (Crespo et al., 2025).

Penyakit yang bersifat kronis progresif atau terminal sering kali menimbulkan dampak signifikan terhadap fungsi sosial pasien dan keluarga. Pasien dapat mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sosial, kehilangan peran produktif dalam keluarga maupun pekerjaan, serta mengalami isolasi sosial akibat perubahan kondisi kesehatan. Situasi tersebut tidak jarang menimbulkan tekanan emosional dan ekonomi bagi keluarga, terutama apabila proses perawatan membutuhkan biaya yang besar atau waktu perawatan yang panjang. Pengkajian sosial yang komprehensif memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi berbagai sumber dukungan yang dapat dimanfaatkan oleh pasien dan keluarga, termasuk dukungan dari komunitas, organisasi sosial, kelompok keagamaan, maupun layanan kesehatan berbasis masyarakat. Pemanfaatan sistem dukungan

sosial tersebut merupakan bagian penting dalam pendekatan *support system* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarga serta membantu mereka beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama perjalanan penyakit (Crespo et al., 2025).

Tabel 1.3 Komponen Pengkajian Dimensi Sosial dan Dukungan Keluarga pada Pasien Paliatif

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Tujuan Pengkajian
Struktur keluarga	Jumlah anggota keluarga, hubungan kekerabatan, anggota keluarga yang tinggal bersama pasien	Mengidentifikasi sistem keluarga yang terlibat dalam perawatan
Hubungan interpersonal	Kualitas komunikasi, kedekatan emosional, pola pengambilan keputusan	Mengetahui kualitas dukungan emosional yang diterima pasien
Peran sosial pasien	Peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat	Menilai perubahan fungsi sosial akibat penyakit
Kondisi ekonomi	Sumber pendapatan keluarga, biaya pengobatan, akses terhadap layanan kesehatan	Mengidentifikasi potensi hambatan ekonomi dalam perawatan
Identifikasi <i>caregiver</i> utama	Anggota keluarga yang bertanggung jawab dalam perawatan harian	Menentukan individu yang membutuhkan dukungan dan edukasi khusus
Dinamika keluarga	Mekanisme koping keluarga, perubahan peran, potensi konflik	Memahami proses adaptasi keluarga terhadap penyakit
Sistem dukungan sosial	Dukungan dari keluarga besar, komunitas, organisasi sosial, atau lembaga keagamaan	Mengoptimalkan pemanfaatan <i>support system</i> bagi pasien dan keluarga

E. Pengkajian Dimensi Spiritual dan Makna Hidup

Dimensi spiritual merupakan salah satu aspek penting dalam pengkajian paliatif karena berkaitan erat dengan cara individu memahami makna kehidupan, penderitaan, serta proses menghadapi penyakit yang mengancam nyawa. Pengkajian spiritual bertujuan untuk mengidentifikasi keyakinan religius, nilai-nilai spiritual, praktik ibadah, serta sumber kekuatan batin yang dimiliki pasien dalam menghadapi kondisi kesehatannya. Keadaan penyakit kronis atau terminal sering

kali memunculkan refleksi mendalam mengenai tujuan hidup, hubungan dengan Tuhan, serta makna penderitaan yang dialami. Pengkajian tersebut memungkinkan perawat memahami bagaimana keyakinan religius dan nilai spiritual memengaruhi sikap pasien terhadap penyakit, proses perawatan, serta kemungkinan menghadapi kematian. Perspektif spiritual sering kali menjadi sumber ketenangan, harapan, serta ketahanan psikologis bagi pasien. Pendekatan yang sensitif terhadap dimensi spiritual menjadi bagian dari praktik *holistic care* yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual secara terpadu (Guadarrama-orozco et al., 2026).

Pengkajian spiritual juga mencakup identifikasi kebutuhan pasien dalam memperoleh dukungan spiritual, baik melalui praktik keagamaan, interaksi dengan tokoh agama, maupun melalui proses refleksi pribadi mengenai makna hidup. Aspek tersebut melibatkan eksplorasi pengalaman spiritual pasien, harapan terhadap masa depan, serta pandangan mengenai kehidupan dan kematian. Pengkajian yang dilakukan secara empatik dan penuh penghargaan terhadap latar belakang budaya serta kepercayaan pasien dapat membantu perawat memahami sumber kekuatan maupun konflik spiritual yang mungkin dialami pasien. Konflik spiritual dapat muncul dalam bentuk perasaan putus asa, kehilangan makna hidup, atau pertanyaan eksistensial mengenai alasan terjadinya penyakit. Identifikasi kondisi tersebut penting untuk menentukan intervensi yang tepat guna mendukung kesejahteraan spiritual pasien. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *patient-centered care* yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap nilai, keyakinan, dan preferensi pasien dalam proses perawatan paliatif (Guadarrama-orozco et al., 2026).

Tabel 1.4 Komponen Pengkajian Dimensi Spiritual pada Pasien Paliatif

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Contoh Pertanyaan Pengkajian
Keyakinan religius	Agama atau sistem kepercayaan yang dianut pasien serta praktik ibadah yang biasa dilakukan	Apa keyakinan atau agama yang menjadi pegangan Bapak atau Ibu dalam kehidupan sehari-hari?
Nilai-nilai spiritual	Nilai kehidupan yang dianggap penting oleh pasien, termasuk hubungan dengan Tuhan dan sesama	Nilai atau prinsip apa yang paling memberikan kekuatan bagi Bapak atau Ibu saat menghadapi penyakit ini?
Makna hidup	Cara pasien memaknai kehidupan, penderitaan, serta	Bagaimana Bapak atau Ibu memaknai pengalaman sakit yang sedang dialami saat ini?

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Contoh Pertanyaan Pengkajian
	pengalaman sakit yang dialami	
Harapan terhadap masa depan	Harapan, tujuan hidup, atau keinginan pasien dalam menjalani sisa kehidupan	Hal apa yang paling Bapak atau Ibu harapkan dalam menjalani perawatan saat ini?
Kebutuhan dukungan spiritual	Kebutuhan akan pendampingan rohani, doa, atau praktik keagamaan tertentu	Apakah Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan dari tokoh agama atau kegiatan spiritual tertentu selama perawatan?
Konflik spiritual	Perasaan kehilangan makna hidup, kemarahan terhadap Tuhan, atau keraguan terhadap keyakinan	Apakah pernah muncul perasaan mempertanyakan makna hidup atau keyakinan selama menghadapi penyakit ini?

F. Pengkajian Kebutuhan Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Paliatif

Pengkajian kebutuhan pasien dan keluarga merupakan komponen esensial dalam praktik perawatan paliatif karena kondisi penyakit yang mengancam nyawa tidak hanya memengaruhi aspek fisik pasien, tetapi juga berdampak luas pada dimensi psikologis, sosial, dan spiritual keluarga yang terlibat dalam proses perawatan. Proses pengkajian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang muncul selama perjalanan penyakit, termasuk kebutuhan informasi mengenai kondisi kesehatan, prognosis penyakit, pilihan terapi, serta rencana perawatan yang tersedia. Informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami menjadi faktor penting dalam membantu pasien dan keluarga memahami situasi yang dihadapi serta meningkatkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi kesehatan. Kebutuhan lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan medis, terutama pada kondisi ketika pasien mengalami penurunan kemampuan dalam menentukan pilihan secara mandiri. Keterlibatan keluarga dalam proses tersebut memerlukan pendekatan komunikasi yang efektif dari tenaga kesehatan agar keputusan yang diambil tetap menghormati nilai, preferensi, dan harapan pasien (Hughes et al., 2025).

Pengkajian kebutuhan juga mencakup identifikasi kebutuhan dukungan emosional dan sosial yang sering kali meningkat seiring dengan perkembangan penyakit. Pasien dan keluarga dapat mengalami berbagai respons emosional seperti kecemasan, ketakutan, kesedihan, hingga kelelahan psikologis akibat beban perawatan jangka panjang. Kondisi tersebut menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan psikososial yang berkelanjutan serta memfasilitasi akses terhadap sumber dukungan yang tersedia di lingkungan pasien. Kebutuhan perawatan di rumah juga menjadi bagian penting dalam pengkajian karena banyak pasien paliatif menjalani sebagian besar proses perawatan di lingkungan keluarga. Persiapan keluarga dalam memberikan perawatan, kemampuan mengelola gejala, serta kesiapan menghadapi fase akhir kehidupan perlu diidentifikasi secara sistematis. Pendekatan *family-centered care* menjadi landasan penting dalam proses ini karena menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan pasien, sekaligus mengakui bahwa kesejahteraan pasien sangat dipengaruhi oleh kondisi, kemampuan, dan kesiapan keluarga dalam memberikan dukungan selama proses penyakit hingga fase akhir kehidupan (Hughes et al., 2025).

Tabel 1.5 Pengkajian Kebutuhan Pasien dan Keluarga dalam Perawatan Paliatif

Aspek Kebutuhan	Deskripsi Pengkajian	Tujuan Pengkajian	Peran Perawat
Kebutuhan informasi	Mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga terkait pemahaman penyakit, prognosis, terapi, dan rencana perawatan	Meningkatkan pemahaman dan kesiapan pasien serta keluarga dalam menghadapi kondisi penyakit	Memberikan edukasi yang jelas, akurat, dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien dan keluarga
Kebutuhan pengambilan keputusan	Menilai kemampuan pasien dan keluarga dalam menentukan pilihan terkait perawatan medis	Memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai, preferensi, dan harapan pasien	Memfasilitasi komunikasi, memberikan informasi yang seimbang, serta mendukung proses <i>shared decision making</i>
Kebutuhan dukungan emosional	Mengidentifikasi respons emosional seperti kecemasan, kesedihan, dan	Membantu pasien dan keluarga mempertahankan	Memberikan dukungan psikologis dan menghubungkan

Aspek Kebutuhan	Deskripsi Pengkajian	Tujuan Pengkajian	Peran Perawat
	ketakutan yang dialami pasien dan keluarga	kesejahteraan psikologis	dengan layanan konseling bila diperlukan
Kebutuhan dukungan sosial	Menilai sistem dukungan sosial yang tersedia, termasuk keluarga, komunitas, dan layanan kesehatan	Memperkuat jejaring dukungan bagi pasien dan keluarga	Mengarahkan pasien dan keluarga pada sumber dukungan yang tersedia
Kebutuhan perawatan di rumah	Mengkaji kesiapan keluarga dalam memberikan perawatan sehari-hari di rumah	Memastikan keberlanjutan perawatan dan kenyamanan pasien	Memberikan pelatihan perawatan dasar dan manajemen gejala kepada keluarga
Kebutuhan persiapan akhir kehidupan	Mengidentifikasi kesiapan pasien dan keluarga dalam menghadapi fase akhir kehidupan	Membantu pasien dan keluarga mempersiapkan diri secara emosional, sosial, dan spiritual	Memberikan pendampingan, komunikasi empatik, serta dukungan selama proses akhir kehidupan

G. Penilaian Kualitas Hidup pada Pasien Paliatif

Kualitas hidup merupakan salah satu indikator utama dalam evaluasi keberhasilan perawatan paliatif pada pasien dengan penyakit mengancam nyawa. Konsep kualitas hidup dalam konteks paliatif tidak hanya berfokus pada kondisi kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang secara keseluruhan memengaruhi pengalaman hidup pasien. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *quality of life* yang menekankan persepsi subjektif individu terhadap kondisi kehidupannya dalam kaitannya dengan nilai, tujuan, harapan, serta standar yang dimilikinya. Kondisi penyakit kronis progresif sering kali menimbulkan berbagai keterbatasan fisik, ketidaknyamanan gejala, perubahan emosional, serta gangguan dalam hubungan sosial dan peran keluarga. Keadaan tersebut menyebabkan kualitas hidup pasien menjadi sangat dinamis dan dapat mengalami perubahan sepanjang perjalanan penyakit. Pengkajian kualitas hidup dalam perawatan paliatif memiliki peran penting dalam memahami dampak penyakit

secara menyeluruh sehingga tenaga kesehatan, khususnya perawat, dapat memberikan asuhan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pasien (Alribdi et al., 2025).

Dimensi kualitas hidup dalam perawatan paliatif umumnya mencakup empat aspek utama, yaitu dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dimensi fisik berkaitan dengan kondisi tubuh serta tingkat kenyamanan pasien, termasuk keberadaan gejala seperti nyeri, kelelahan, gangguan tidur, serta keterbatasan aktivitas sehari-hari. Dimensi psikologis berkaitan dengan kondisi emosional pasien yang meliputi perasaan cemas, depresi, ketakutan terhadap kematian, serta kemampuan individu dalam mengelola stres akibat penyakit yang dialami. Dimensi sosial berhubungan dengan kualitas hubungan interpersonal, dukungan keluarga, serta kemampuan pasien dalam mempertahankan peran sosialnya di lingkungan masyarakat. Dimensi spiritual berkaitan dengan keyakinan, nilai, makna hidup, serta harapan pasien dalam menghadapi kondisi penyakit yang progresif. Penilaian terhadap keempat dimensi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pasien sehingga tenaga kesehatan dapat memahami kebutuhan pasien secara lebih mendalam. Pemahaman yang holistik terhadap kualitas hidup juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi prioritas dalam proses perawatan (Getie, 2025).

Penilaian kualitas hidup pada pasien paliatif umumnya dilakukan menggunakan berbagai instrumen pengukuran yang telah dikembangkan secara ilmiah dan memiliki validitas serta reliabilitas yang baik. Beberapa instrumen yang sering digunakan dalam praktik perawatan paliatif antara lain *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)*, *European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ)*, serta *McGill Quality of Life Questionnaire (MQOL)*. Instrumen tersebut memungkinkan tenaga kesehatan memperoleh informasi yang sistematis mengenai persepsi pasien terhadap kondisi kesehatannya serta dampak penyakit terhadap kehidupannya. Hasil penilaian kualitas hidup kemudian digunakan sebagai dasar dalam merencanakan intervensi keperawatan yang lebih tepat, termasuk pengelolaan gejala, dukungan psikososial, serta pemenuhan kebutuhan spiritual pasien. Informasi tersebut juga dapat membantu tim kesehatan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan serta menyesuaikan rencana perawatan secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut mendukung tercapainya tujuan utama perawatan paliatif, yaitu meningkatkan kenyamanan, martabat, serta kualitas hidup pasien selama menjalani proses penyakit (Dong et al., 2025; Grudzen et al., 2025).

Tabel 1.6 Dimensi Penilaian Kualitas Hidup pada Pasien Paliatif

Dimensi Kualitas Hidup	Fokus Penilaian	Contoh Indikator
Fisik	Kondisi tubuh dan tingkat kenyamanan pasien	Nyeri, kelelahan, mual, gangguan tidur, keterbatasan aktivitas
Psikologis	Kondisi emosional dan mental pasien	Kecemasan, depresi, ketakutan terhadap kematian, kemampuan coping
Sosial	Hubungan interpersonal dan dukungan sosial	Dukungan keluarga, hubungan dengan orang terdekat, peran sosial
Spiritual	Nilai, keyakinan, dan makna hidup	Keyakinan religius, harapan, penerimaan terhadap penyakit, pencarian makna hidup

H. Penutup

Pengkajian paliatif komprehensif merupakan komponen fundamental dalam praktik keperawatan paliatif karena memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Proses pengkajian yang mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual memungkinkan tenaga kesehatan memahami pengalaman pasien secara menyeluruh serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kualitas hidupnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *holistic care* yang menempatkan manusia sebagai makhluk multidimensional dengan kebutuhan yang saling berkaitan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi pasien membantu perawat menentukan prioritas intervensi, mengelola gejala secara efektif, serta memberikan dukungan psikososial yang sesuai dengan kondisi pasien dan keluarganya.

Pelaksanaan pengkajian paliatif yang sistematis juga mendukung terciptanya kolaborasi yang efektif dalam tim kesehatan multidisiplin. Hasil pengkajian menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan klinis serta evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang telah diberikan. Pendekatan yang berpusat pada pasien dan keluarga memungkinkan proses perawatan berjalan secara lebih empatik, manusiawi, dan bermakna bagi pasien yang menghadapi penyakit mengancam nyawa. Penerapan pengkajian paliatif komprehensif secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan serta membantu pasien

menjalani proses penyakit dengan kenyamanan, martabat, dan kualitas hidup yang optimal.

Referensi

- Alribdi, F., Aljaloud, M., Alqwaee, A., Alfawzan, A., Camba, A., Alanazi, A. F., & Alharbi, M. M. (2025). *Health-Related Quality of Life and Patient Experience in Oncology Palliative Care Within the Saudi Model of Care Framework: Evidence from the Qassim Health Cluster, Saudi Arabia*.
- Crespo, I., Goni-fuste, B., & Monforte-royo, C. (2025). *Implementation of a clinical interview guide to Multidimensional needs assessment in Palliative care (MAP): A multicenter mixed-methods feasibility study*. 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329354>
- Dong, X., Liu, Y., Fang, K., Wang, Z., & Vitoria, U. F. De. (2025). *Latent profile analysis of nurses ' the quality of palliative nursing*. May, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1537851>
- Dookie, S. P. (2025). *The effect of language discordance on the experience of palliative care: A scoping review*. 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321075>
- Getie, A. (2025). *Comparative Impact of Integrated Palliative Care vs . Standard Care on the Quality of Life in Cancer Patients: A Global Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials*. 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321586>
- Grudzen, C. R., Flannery, M., Allen, K. Van, Cuthel, A., Yamarik, R. L., Tan, A., Cohen, S. E., Barker, P. C., Brody, A. A., Herchek, C., Siman, N., Goldfeld, K. S., & Group, E. (2025). *Nurse led telephonic palliative care versus specialty outpatient palliative care: pragmatic , randomised clinical trial*. <https://doi.org/10.1136/bmjmed-2025-001392>
- Guadarrama-orozco, J. H., Mendoza-martínez, M. G., & Bautista-téllez, S. E. (2026). *Improved Quality of Life in Children and Families Following Enrollment in a Pediatric Palliative Care Program: A Prospective Cohort Study*. 1–10.
- Hughes, A., Davies, N., Zhou, Y., Moore, K., Aworinde, T., Ellis-smith, C., Sleeman, K., Barrado-martin, Y., Evans, C., Sampson, E. L., Kenten, C., Henderson, C., & Vickerstaff, V. (2025). *Interventions to improve quality of life for informal caregivers of people with dementia nearing the end of life: A meta-review and system-based logic model*. 21, 4–6. <https://doi.org/10.1002/alz70858>

- Nejatifar, Z., Alizadeh, A., Amerzadeh, M., Omidian, S., & Rafiei, S. (2025). The predictive role of identifying frailty in assessing the need for palliative care in the elderly : the application of machine learning algorithm. *Journal of Health, Population and Nutrition*. <https://doi.org/10.1186/s41043-025-00841-2>
- Pastrana, T., Grant, M., Andrade, P. H., Marelli, D., Witte, K., Geersing, G., Ripamonti, C., Rolke, R., Metra, M., Pagnesi, M., Graaf, E. De, & Chelazzi, C. (2025). *Mapping of current practices of palliative care for patients with heart failure throughout Europe : A scoping review*. September, 4021–4032. <https://doi.org/10.1002/ehf2.15431>

BAB II

KONTROL GEJALA UTAMA

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif merupakan pendekatan holistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit mengancam jiwa melalui pencegahan dan pengurangan penderitaan. Pendekatan ini mencakup pengelolaan masalah fisik, psikologis, sosial, dan spiritual secara terintegrasi. Pasien dengan penyakit terminal sering mengalami berbagai gejala kompleks yang muncul secara bersamaan dan saling memengaruhi. Kontrol gejala merupakan komponen utama dalam perawatan paliatif. Gejala seperti nyeri, sesak napas, mual muntah, konstipasi, delirium, kelelahan, serta gangguan tidur sering kali menjadi sumber penderitaan utama pasien. Jika tidak ditangani secara optimal, gejala-gejala tersebut dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan dan memperburuk kondisi klinis pasien. Kontrol gejala utama dalam perawatan paliatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius, kronis, atau terminal (seperti kanker stadium lanjut, gagal jantung, atau PPOK) melalui pendekatan holistik yang mencakup fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Prinsip utama kontrol gejala dalam perawatan paliatif adalah berfokus pada kenyamanan pasien, bukan penyembuhan penyakit, dan seringkali dilakukan melalui *home care* (perawatan di rumah) untuk meminimalkan beban keluarga. Tim paliatif terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, pekerja sosial, dan rohaniawan.

B. Kontrol Gejala Utama Dalam Perawatan Paliatif

1. Nyeri

Nyeri merupakan salah satu gejala yang paling sering muncul pada pasien dalam fase akhir kehidupan dan menjadi perhatian utama dalam perawatan paliatif. Pengalaman nyeri bersifat sangat subjektif, di mana setiap individu merasakan dan mengekspresikan nyeri secara berbeda. Tidak semua pasien yang membutuhkan perawatan paliatif mengalami nyeri yang menetap, namun berbagai kondisi seperti kelelahan, kecemasan, ketakutan, atau kegelisahan dapat memperberat persepsi nyeri yang dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa nyeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga oleh aspek psikologis dan emosional.

Meskipun perkembangan dalam bidang manajemen nyeri telah mengalami kemajuan yang signifikan, pada beberapa kondisi nyeri mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, tujuan utama pengelolaan nyeri dalam perawatan paliatif adalah mengurangi intensitas nyeri hingga tingkat yang dapat ditoleransi serta meningkatkan kenyamanan pasien. Pendekatan yang digunakan umumnya mengacu pada prinsip tangga analgesik yang direkomendasikan oleh WHO, dimulai dari penggunaan analgesik non-opioid hingga opioid kuat sesuai dengan tingkat keparahan nyeri. Selain itu, intervensi psikologis dan dukungan emosional juga menjadi bagian integral dalam membantu pasien menghadapi nyeri secara lebih adaptif.

Penilaian terhadap nyeri merupakan langkah krusial dalam menentukan strategi penatalaksanaan yang tepat. Tim perawatan paliatif dan dokter akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jika nyeri berubah atau mengkhawatirkan, hubungi dokter umum atau tim perawatan paliatif. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan kepada pasien diantaranya: Di mana rasa sakitnya? Sudah berapa lama rasa sakit itu muncul? Jenis nyeri apa yang Anda rasakan – tajam, kesemutan, atau pegal? Apakah ini jenis nyeri yang baru? Apakah rasa sakitnya menetap, atau datang dan pergi? Apakah ada perubahan gaya hidup lainnya yang terjadi? Apakah merasa ingin muntah? dan Kapan terakhir kali buang air besar? (Sembelit dapat menyebabkan rasa sakit.). Penilaian intensitas nyeri umumnya menggunakan skala numerik dari 0 hingga 10, 1 berarti 'tidak sakit' hingga 10 berarti 'sakit yang luar biasa. Skor di atas 4 menunjukkan perlunya intervensi yang lebih serius dan perlu segera ditangani.

Manajemen nyeri yang efektif merupakan bagian esensial dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengendalian nyeri yang baik memungkinkan pasien untuk beristirahat dengan lebih optimal, meningkatkan energi di siang hari, serta mempertahankan aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan. Dengan demikian, risiko komplikasi akibat imobilisasi juga dapat diminimalkan. Selain intervensi farmakologis, berbagai strategi non-farmakologis dapat diterapkan untuk membantu mengurangi nyeri. Teknik sederhana untuk membantu mengatasi rasa sakit sehingga dapat memberikan efek positif dalam menurunkan persepsi nyeri, diantaranya pengaturan posisi yang nyaman dengan berbaring ditempat tidur atau duduk, latihan pernapasan dalam, serta distraksi melalui aktivitas seperti membaca, menonton, atau mendengarkan musik. Dalam praktiknya, penting bagi pasien dan keluarga untuk mengenali faktor-faktor lain yang dapat memperburuk nyeri, seperti mual atau konstipasi. Kondisi tersebut perlu ditangani secara tepat karena dapat menjadi sumber ketidaknyamanan tambahan. Apabila nyeri tidak membaik dalam waktu tertentu atau mengalami

perubahan yang signifikan, pasien dianjurkan untuk segera berkonsultasi dengan tim perawatan paliatif agar penyesuaian terapi dapat dilakukan secara tepat.

Penggunaan obat pereda nyeri atau analgesik merupakan komponen utama dalam manajemen nyeri, dan sering digunakan pada perawatan paliatif. Penggunaan obat harus mengikuti anjuran tenaga kesehatan untuk memastikan efektivitas dan keamanan terapi. Dalam jangka panjang, beberapa obat dapat mengalami penurunan efektivitas atau menimbulkan efek samping, sehingga diperlukan evaluasi berkala oleh tenaga medis. Selain itu, penting bagi pasien untuk menginformasikan penggunaan obat lain, termasuk obat bebas, herbal, atau suplemen, guna menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Beri tahu dokter jika sedang mengonsumsi (atau akan mengonsumsi) obat bebas, obat herbal, atau suplemen alami karena obat-obatan tersebut dapat bereaksi dengan obat lain yang dikonsumsi. Pastikan selalu menyediakan obat pereda nyeri dalam jumlah yang cukup agar tidak kehabisan.

Salah satu kelompok obat yang sering digunakan dalam manajemen nyeri paliatif adalah opioid, seperti morfin. Opioid umumnya diberikan pada nyeri sedang hingga berat yang tidak responsif terhadap analgesik ringan. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran di masyarakat terkait penggunaan opioid, terutama mengenai risiko ketergantungan dan anggapan bahwa obat ini dapat mempercepat kematian. Dalam konteks perawatan paliatif, penggunaan opioid yang tepat dan sesuai indikasi tidak menyebabkan kecanduan. Selain itu, kematian pasien lebih berkaitan dengan progresivitas penyakit yang mendasari, bukan akibat penggunaan opioid yang diberikan secara terkontrol. Pemahaman yang baik mengenai manfaat dan efek samping opioid sangat penting bagi pasien dan keluarga. Tenaga kesehatan akan memberikan edukasi terkait penggunaan obat, serta melakukan pemantauan terhadap efek samping seperti mual atau konstipasi. Apabila efek samping muncul, dokter dapat melakukan penyesuaian dosis atau memberikan terapi tambahan untuk mengatasinya.

Sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan, pencatatan nyeri melalui buku harian nyeri dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Dengan mencatat nyeri setiap kali muncul, tim perawatan kesehatan dapat memantau perubahan dan memastikan obat-obatan bekerja dengan benar. Bagan pengobatan juga merupakan alat yang berguna yang dapat membantu mengingat untuk minum obat, dosis yang tepat, dan mencatat perubahan serta perkembangan gejala.

2. Sesak napas

Sesak napas atau dyspnea merupakan salah satu gejala yang sering dialami oleh pasien dalam perawatan paliatif dan menjadi sumber ketidaknyamanan yang signifikan. Dyspnea didefinisikan sebagai pengalaman subjektif berupa sensasi

tidak menyenangkan terkait kesulitan bernapas. Persepsi ini dapat bervariasi antar individu, baik dari segi intensitas maupun dampaknya terhadap kualitas hidup. Pada banyak kasus, dyspnea tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga memicu respons emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi pasien secara keseluruhan.

Berbagai kondisi dapat menjadi penyebab sesak napas pada pasien paliatif, di antaranya penyakit paru kronis seperti asma dan emfisema, infeksi saluran pernapasan, efusi pleura, serta tekanan dari organ lain akibat proses penyakit. Selain faktor fisik, aspek psikologis seperti kecemasan juga berperan penting dalam memperberat persepsi dyspnea. Hubungan timbal balik antara sesak napas dan kecemasan sering kali membentuk suatu siklus yang saling memperburuk, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional.

Pengelolaan dyspnea dalam perawatan paliatif bertujuan untuk mengurangi sensasi sesak dan meningkatkan kenyamanan pasien. Pendekatan non-farmakologis merupakan langkah awal yang penting dan sering kali memberikan manfaat yang signifikan. Beberapa tindakan yang dapat membantu antara lain: 1. Duduk tegak. pengaturan posisi tubuh (posisi duduk/semi-fowler), 2. menyalakan kipas angin atau buka jendela. penggunaan kipas angin untuk aliran udara di wajah, 3. mengenakan pakaian yang longgar, 4. memutar musik yang menenangkan, 5. teknik relaksasi. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional melalui kehadiran yang lembut dan menenangkan, bisa menawarkan pijatan kaki, tangan, atau bahu, atau memegang tangan mereka, jika itu membuat klien merasa lebih baik.

Selain intervensi non-farmakologis, terapi farmakologis juga merupakan komponen penting dalam manajemen dyspnea. Salah satu obat yang sering digunakan adalah opioid, seperti morfin, yang terbukti efektif dalam mengurangi sensasi sesak napas melalui mekanisme modulasi persepsi pusat terhadap pernapasan. Penggunaan obat harus dilakukan sesuai dengan resep dan pemantauan tenaga kesehatan untuk memastikan efektivitas serta mencegah efek samping yang tidak diinginkan.

Dalam praktik klinis, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap respons pasien terhadap terapi yang diberikan. Apabila sesak napas tidak membaik atau justru semakin memburuk hingga menyebabkan distress yang signifikan, maka diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter atau tim perawatan paliatif untuk penyesuaian intervensi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada pasien, pengelolaan dyspnea diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup pasien dalam perawatan paliatif.

3. Mual Muntah

Mual dan muntah merupakan gejala yang sering dijumpai pada pasien dalam perawatan paliatif dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup. Mual didefinisikan sebagai sensasi tidak nyaman yang sering kali disertai dorongan untuk muntah, sedangkan muntah merupakan refleksi kompleks yang menyebabkan pengeluaran isi lambung melalui mulut. Kedua gejala ini sering muncul secara bersamaan, namun juga dapat terjadi secara terpisah, dengan tingkat keparahan yang bervariasi pada setiap individu.

Dalam konteks perawatan paliatif, mual dan muntah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebab yang paling umum meliputi efek langsung dari penyakit yang mendasari, efek samping pengobatan seperti kemoterapi dan radioterapi, gangguan pada sistem gastrointestinal seperti konstipasi atau obstruksi, serta ketidakseimbangan metabolik. Selain itu, peningkatan tekanan intrakranial dan faktor psikologis seperti kecemasan juga dapat berkontribusi terhadap munculnya gejala ini. Kompleksitas etiologi tersebut menuntut pendekatan pengkajian yang komprehensif agar intervensi yang diberikan dapat disesuaikan secara tepat. Jika telah diresepkan obat anti-mual, minumlah sesuai petunjuk, kecuali jika memikirkan untuk mencoba minum tablet membuat merasa lebih buruk.

Penatalaksanaan mual dan muntah dalam perawatan paliatif berfokus pada pengendalian gejala dan peningkatan kenyamanan pasien. Pendekatan farmakologis merupakan komponen utama, terutama melalui penggunaan obat antiemetik yang disesuaikan dengan mekanisme penyebab. Penggunaan obat harus mengikuti anjuran tenaga kesehatan untuk memastikan efektivitas terapi serta meminimalkan risiko efek samping. Di samping terapi farmakologis, pendekatan non-farmakologis juga memiliki peran penting dalam mengurangi gejala. Respons pasien terhadap makanan dan minuman dapat bervariasi; sebagian pasien mungkin merasa lebih nyaman dengan membatasi asupan sementara hingga mual mereda, sedangkan sebagian lainnya justru terbantu dengan mengonsumsi makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada preferensi pasien sangat dianjurkan.

Intervensi sederhana seperti istirahat yang cukup, latihan pernapasan dalam, serta distraksi melalui musik yang menenangkan dapat membantu mengurangi persepsi mual. Selain itu, terapi komplementer seperti pijat ringan atau mandi hangat juga dilaporkan dapat memberikan efek relaksasi yang berkontribusi terhadap penurunan gejala. Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi faktor pencetus, memantau respons terhadap intervensi, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai strategi pengelolaan yang efektif.

Evaluasi terhadap gejala harus dilakukan secara berkelanjutan. Apabila mual tidak membaik dalam waktu tertentu atau justru mengalami perburukan, diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter atau tim perawatan paliatif untuk melakukan penyesuaian terapi. Pendekatan yang sistematis dan individualisasi intervensi menjadi kunci dalam pengelolaan mual dan muntah, sehingga kenyamanan pasien dapat terjaga secara optimal dalam perawatan paliatif. Penanganan disesuaikan dengan penyebabnya (misal: gangguan lambung, efek samping obat, atau tekanan intrakranial) menggunakan obat antiemetik)

4. Cahexia

Caheksia merupakan suatu sindrom klinis kompleks yang sering dijumpai pada pasien dengan penyakit kronis dan mengancam jiwa, khususnya pada kanker stadium lanjut. Istilah kaheksia berasal dari bahasa Yunani, yaitu kakos yang berarti "buruk" dan hexis yang berarti "kondisi", yang secara keseluruhan menggambarkan keadaan penurunan kondisi fisik yang berat. Meskipun caheksia bukan merupakan gejala tunggal, kondisi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan gejala lain seperti anoreksia dan kelelahan, sehingga sering dibahas dalam konteks manajemen gejala pada perawatan paliatif.

Secara konseptual, caheksia dipahami sebagai suatu proses penurunan berat badan yang bersifat multidimensional dan tidak sepenuhnya dapat diperbaiki hanya dengan peningkatan asupan nutrisi. Kondisi ini ditandai oleh hilangnya massa otot rangka, dengan atau tanpa kehilangan lemak tubuh, yang berkontribusi terhadap penurunan fungsi fisik pasien. Salah satu mekanisme utama dalam caheksia adalah anoreksia primer, yaitu penurunan nafsu makan yang menyebabkan berkurangnya asupan oral. Kondisi ini sering diperburuk oleh faktor sekunder seperti mual, muntah, gangguan menelan, nyeri, atau efek samping terapi, yang semakin menurunkan kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.

Selain penurunan asupan nutrisi, caheksia juga dipengaruhi oleh perubahan metabolisme yang kompleks. Proses inflamasi sistemik yang terjadi pada penyakit kronis memicu peningkatan katabolisme dan gangguan metabolisme energi, sehingga tubuh mengalami kehilangan massa otot secara progresif meskipun asupan nutrisi telah ditingkatkan. Hal ini membedakan caheksia dari malnutrisi biasa, di mana peningkatan asupan nutrisi umumnya dapat memperbaiki kondisi pasien.

Dalam konteks perawatan paliatif, caheksia memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Penurunan berat badan, kelemahan otot, dan kelelahan yang menyertai kondisi ini dapat membatasi aktivitas sehari-hari serta meningkatkan ketergantungan pasien terhadap orang lain. Selain itu,

perubahan penampilan fisik akibat penurunan berat badan sering kali menimbulkan distress emosional baik bagi pasien maupun keluarga.

Penatalaksanaan kaheksia dalam perawatan paliatif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kenyamanan pasien. Intervensi yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi, tetapi juga untuk mengurangi gejala yang menyertai serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pendekatan nutrisi yang bersifat suportif, seperti pemberian makanan dalam porsi kecil namun sering, serta pemilihan makanan yang sesuai dengan preferensi pasien, dapat membantu meningkatkan asupan oral. Selain itu, terapi farmakologis seperti penggunaan agen stimulasi nafsu makan atau kortikosteroid dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu.

Peran perawat sangat penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kaheksia, memantau status nutrisi pasien, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi yang dialami. Komunikasi yang efektif juga diperlukan untuk membantu keluarga memahami bahwa penurunan nafsu makan dan berat badan merupakan bagian dari proses penyakit, sehingga dapat mengurangi kecemasan dan harapan yang tidak realistis terhadap peningkatan asupan makanan.

5. Konstipasi

Konstipasi merupakan salah satu masalah gastrointestinal yang paling sering dijumpai pada pasien dalam perawatan paliatif. Kondisi ini umumnya ditandai dengan penurunan frekuensi buang air besar, kesulitan dalam proses defekasi, atau perubahan konsistensi feses menjadi lebih keras. Pada pasien paliatif, konstipasi tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap munculnya gejala lain seperti mual, nyeri abdomen, distensi perut, serta kelelahan, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penyebab konstipasi pada pasien paliatif bersifat multifaktorial. Faktor yang sering berperan antara lain asupan cairan yang tidak adekuat, pola makan rendah serat, serta penurunan aktivitas fisik akibat kondisi penyakit. Selain itu, imobilisasi yang berkepanjangan dan kelemahan umum pada pasien turut memperlambat motilitas usus. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah efek samping terapi, khususnya penggunaan opioid seperti morfin, yang diketahui dapat menurunkan peristaltik usus dan meningkatkan absorpsi cairan di kolon, sehingga menyebabkan feses menjadi lebih keras.

Dalam praktik perawatan paliatif, konstipasi sering kali dapat diprediksi, terutama pada pasien yang mendapatkan terapi opioid. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan menjadi sangat penting dan sebaiknya dilakukan secara proaktif. Penatalaksanaan konstipasi mencakup kombinasi intervensi non-

farmakologis dan farmakologis yang disesuaikan dengan kondisi dan toleransi pasien.

Pendekatan non-farmakologis meliputi pengaturan pola makan dan hidrasi. Peningkatan asupan cairan, seperti air putih atau jus, dapat membantu melunakkan feses dan mempermudah proses defekasi. Konsumsi makanan yang kaya serat juga dianjurkan untuk meningkatkan massa feses dan merangsang pergerakan usus, meskipun perlu disesuaikan dengan kondisi pasien, terutama pada mereka yang mengalami gangguan gastrointestinal tertentu. Aktivitas fisik ringan, seperti berjalan singkat sesuai kemampuan, juga dapat membantu merangsang motilitas usus.

Terapi farmakologis juga memegang peranan penting, terutama pada pasien dengan konstipasi yang berkaitan dengan penggunaan opioid. Pemberian laksatif secara rutin sering direkomendasikan sebagai bagian dari terapi profilaksis. Jenis laksatif yang digunakan dapat berupa laksatif stimulan atau osmotik, tergantung pada kondisi klinis pasien. Dalam beberapa kasus, penggunaan obat perangsang nafsu makan juga dapat membantu meningkatkan asupan nutrisi yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap perbaikan fungsi gastrointestinal.

Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda konstipasi sejak dini, memantau pola eliminasi pasien, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai strategi pencegahan dan penanganan konstipasi. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius, seperti impaksi fekal, yang dapat memperburuk kondisi pasien.

6. Anoreksia

Anoreksia merupakan salah satu gejala yang sering dijumpai pada pasien dengan penyakit stadium lanjut dan menjadi masalah yang signifikan dalam perawatan paliatif. Secara klinis, anoreksia didefinisikan sebagai penurunan atau hilangnya nafsu makan yang dapat berdampak pada berkurangnya asupan nutrisi. Kondisi ini sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi disertai dengan gejala lain seperti cepat merasa kenyang (early satiety), mual, konstipasi, mulut kering, serta nyeri abdomen. Kombinasi gejala tersebut dapat memperburuk status nutrisi pasien dan berkontribusi terhadap penurunan berat badan serta kelemahan umum.

Dalam konteks perawatan paliatif, anoreksia memiliki etiologi yang kompleks dan multifaktorial. Faktor penyebabnya dapat berasal dari proses penyakit itu sendiri, efek samping terapi, gangguan metabolik, maupun gejala lain yang menyertai seperti nyeri dan mual. Selain itu, perubahan fisiologis pada fase lanjut penyakit juga dapat memengaruhi regulasi nafsu makan dan metabolisme energi, sehingga memperburuk kondisi anoreksia.

Anoreksia pada pasien dengan penyakit stadium lanjut berbeda dengan anoreksia nervosa. Anoreksia dalam konteks paliatif bukan merupakan gangguan psikiatrik yang disebabkan oleh distorsi citra tubuh, melainkan bagian dari proses penyakit yang kompleks. Namun demikian, karena makan memiliki makna sosial dan emosional yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, penurunan nafsu makan sering kali menimbulkan distress, baik bagi pasien maupun keluarga. Keluarga sering kali merasa khawatir atau bahkan bersalah ketika pasien tidak mampu makan dengan baik, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang sensitif dan edukatif dari tenaga kesehatan.

Penatalaksanaan anoreksia dalam perawatan paliatif berfokus pada peningkatan kenyamanan pasien serta optimalisasi kualitas hidup, bukan semata-mata pada peningkatan berat badan. Pendekatan yang dilakukan meliputi identifikasi dan koreksi faktor penyebab yang dapat dimodifikasi, seperti mengatasi mual, konstipasi, nyeri, atau mulut kering. Intervensi nutrisi yang bersifat suportif, seperti pemberian makanan dalam porsi kecil namun sering, serta pemilihan makanan sesuai preferensi pasien, dapat membantu meningkatkan asupan secara bertahap. Selain itu, terapi farmakologis dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu, seperti penggunaan kortikosteroid atau agen stimulasi nafsu makan untuk meningkatkan intake nutrisi. Namun, penggunaan terapi ini harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh serta potensi efek samping yang mungkin timbul.

Perawat memiliki peran penting dalam mengkaji status nutrisi, memantau perubahan pola makan, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kondisi anoreksia. Komunikasi yang empatik sangat diperlukan untuk membantu keluarga memahami bahwa penurunan nafsu makan merupakan bagian dari perjalanan penyakit, sehingga dapat mengurangi tekanan yang tidak perlu terhadap pasien.

7. Delirium

Delirium merupakan suatu sindrom neuropsikiatri akut yang ditandai dengan gangguan kesadaran, perhatian, kognisi, dan persepsi yang terjadi secara mendadak serta berfluktuasi. Kondisi ini sering dijumpai pada pasien dalam perawatan paliatif, terutama pada fase penyakit lanjut, dan menjadi salah satu penyebab utama distress baik bagi pasien maupun keluarga. Delirium tidak hanya memengaruhi fungsi kognitif, tetapi juga berdampak pada perilaku dan emosi pasien, sehingga dapat mengganggu proses perawatan secara keseluruhan.

Secara klinis, delirium ditandai oleh perubahan cepat dalam tingkat kesadaran dan kemampuan berpikir. Pasien dapat mengalami kebingungan yang tiba-tiba, gangguan memori jangka pendek, kesulitan berkonsentrasi, serta penurunan kemampuan untuk memahami lingkungan sekitar. Selain itu, perubahan perilaku dan suasana hati sering terjadi secara fluktuatif, termasuk

agitasi, apati, atau perubahan emosional yang tidak stabil. Pada beberapa kasus, pasien juga dapat mengalami disorientasi terhadap waktu, tempat, maupun orang, serta kesulitan membedakan antara siang dan malam. Manifestasi lain yang sering muncul adalah halusinasi atau ilusi, yang dapat memperburuk kecemasan dan ketakutan pasien.

Penyebab delirium dalam perawatan paliatif bersifat multifaktorial. Gangguan fungsi otak yang mendasari kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti dehidrasi, infeksi, gangguan metabolik, efek samping obat, serta kondisi pascaoperasi. Selain itu, pasien usia lanjut atau mereka yang memiliki gangguan kognitif sebelumnya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami delirium. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut sering kali memperumit proses diagnosis dan penatalaksanaan.

Penatalaksanaan delirium dalam perawatan paliatif berfokus pada identifikasi dan koreksi penyebab yang mendasari, serta pengendalian gejala untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Dalam banyak kasus, delirium bersifat reversibel apabila faktor pencetus dapat diatasi. Namun, pada pasien dengan kondisi penyakit yang sangat lanjut atau mendekati akhir hayat, delirium mungkin tidak dapat sepenuhnya diatasi, sehingga pendekatan perawatan lebih diarahkan pada upaya suportif dan paliatif.

Intervensi non-farmakologis merupakan komponen penting dalam manajemen delirium. Lingkungan yang tenang dan terstruktur dapat membantu mengurangi kebingungan pasien. Komunikasi yang jelas, perlahan, dan konsisten sangat dianjurkan, termasuk dengan memberikan orientasi ulang secara berkala mengenai identitas, lokasi, dan situasi yang sedang dihadapi pasien. Kehadiran keluarga atau orang terdekat juga dapat memberikan rasa aman dan membantu proses orientasi pasien.

Selain itu, penting untuk menghindari stimulasi berlebihan, seperti kebisingan atau jumlah pengunjung yang terlalu banyak, karena dapat memperburuk gejala delirium. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti hidrasi yang adekuat, juga harus diperhatikan, mengingat dehidrasi merupakan salah satu faktor pencetus yang sering terjadi. Perawat memiliki peran sentral dalam memantau perubahan status mental pasien, mengidentifikasi tanda-tanda delirium sejak dini, serta berkoordinasi dengan tim medis untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Apabila diperlukan, terapi farmakologis dapat diberikan untuk mengendalikan gejala yang berat, seperti agitasi atau halusinasi yang mengganggu. Namun, penggunaan obat harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara menyeluruh. Beri tahu dokter umum atau tim perawatan paliatif jika merasa ada perubahan yang mungkin disebabkan oleh delirium. Berikan informasi sebanyak mungkin tentang riwayat

kesehatan terkini. Dokter umum atau tim perawatan paliatif mungkin juga akan menanyakan tentang masalah ingatan yang pernah di alami sebelumnya. Informasi ini dapat membantu mendiagnosis penyebab delirium dan mencegah kekambuhannya.

8. Kelelahan

Kelelahan (fatigue) merupakan salah satu gejala yang paling sering dialami oleh pasien dalam perawatan paliatif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup. Secara umum, kelelahan dapat dipahami sebagai perasaan lelah yang bersifat subjektif. Dalam kondisi normal, kelelahan biasanya dapat diatasi dengan istirahat yang cukup. Namun, dalam konteks klinis, khususnya pada pasien dengan penyakit mengancam jiwa, kelelahan memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu persisten, tidak proporsional terhadap aktivitas yang dilakukan, dan tidak membaik secara bermakna meskipun telah beristirahat. Dalam literatur klinis, istilah kelelahan sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti *asthenia*, *lethargy*, atau *cancer-related fatigue*. Istilah *asthenia* sendiri merujuk pada kondisi berkurangnya kekuatan fisik, yang berasal dari bahasa Yunani *a* (tanpa) dan *sthenos* (kekuatan). Meskipun belum terdapat definisi tunggal yang disepakati secara universal, seluruh istilah tersebut menggambarkan kondisi yang melemahkan dan mengganggu fungsi fisik, emosional, serta sosial pasien.

Kelelahan pada pasien paliatif merupakan kondisi yang kompleks dan multifaktorial. Penyebabnya dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk gangguan tidur, hipoksia (kadar oksigen rendah dalam darah), malnutrisi, infeksi, serta efek samping terapi seperti kemoterapi atau radioterapi. Selain itu, faktor psikologis seperti depresi dan kecemasan juga dapat memperburuk persepsi kelelahan. Dalam banyak kasus, kelelahan juga merupakan manifestasi langsung dari proses penyakit yang mendasari, terutama pada kondisi kronis dan terminal.

Dampak kelelahan terhadap pasien sangat luas. Kondisi ini dapat menurunkan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengurangi partisipasi dalam interaksi sosial, serta menimbulkan perasaan frustrasi dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pengelolaan kelelahan menjadi bagian penting dalam perawatan paliatif dengan tujuan utama meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup pasien.

Penatalaksanaan kelelahan dalam perawatan paliatif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan individual. Intervensi non-farmakologis menjadi strategi utama yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Pengaturan pola istirahat yang efektif, seperti tidur siang dalam durasi singkat, dapat membantu mengurangi kelelahan tanpa mengganggu pola tidur malam. Selain itu, aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara teratur, seperti berjalan singkat, dapat meningkatkan energi dan memperbaiki fungsi fisik.

Asupan nutrisi yang adekuat juga memegang peranan penting dalam mengatasi kelelahan. Konsumsi makanan dan minuman yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan mendukung proses pemulihan. Pasien juga dianjurkan untuk merencanakan aktivitas sehari-hari dengan mempertimbangkan tingkat energi yang dimiliki, misalnya melakukan aktivitas yang membutuhkan tenaga lebih besar pada saat energi sedang optimal. Selain itu, strategi konservasi energi merupakan pendekatan penting lainnya dalam manajemen kelelahan, terutama pada kondisi kelelahan yang berat. Pasien didorong untuk memprioritaskan aktivitas yang penting, mengatur waktu istirahat secara seimbang, serta memanfaatkan bantuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Keterlibatan dalam aktivitas ringan yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, membaca, atau menonton, dapat membantu mengalihkan perhatian dari rasa lelah dan meningkatkan kesejahteraan emosional.

Perawat memiliki peran sentral dalam mengkaji tingkat kelelahan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai strategi pengelolaan yang efektif. Evaluasi berkala sangat diperlukan untuk memantau perkembangan kondisi pasien. Apabila kelelahan semakin memburuk atau tidak terkontrol, diperlukan konsultasi dengan tim perawatan paliatif untuk mempertimbangkan intervensi tambahan, termasuk terapi farmakologis bila diperlukan.

9. Masalah tidur

Gangguan tidur merupakan masalah yang sering dijumpai pada pasien dalam perawatan paliatif dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup. Salah satu bentuk gangguan tidur yang dapat terjadi adalah sleep phase disorder (SPD), yaitu kondisi ketika siklus tidur–bangun seseorang mengalami pergeseran sehingga pasien kesulitan untuk tidur pada waktu yang diharapkan serta mengalami kesulitan untuk bangun pada pagi hari. Pada pasien dengan penyakit kronis dan mengancam jiwa, gangguan ini sering kali diperburuk oleh penurunan kondisi fisik, ketidaknyamanan akibat gejala penyakit, serta faktor psikologis seperti kecemasan dan depresi.

Gangguan tidur pada pasien paliatif tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial. Kurang tidur dapat memperburuk kelelahan, menurunkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan sensitivitas terhadap nyeri. Selain itu, gangguan tidur juga berkontribusi terhadap penurunan fungsi kognitif dan stabilitas emosi pasien. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan, terutama pada pasien yang sudah mengalami berbagai gejala kompleks lainnya.

Dampak gangguan tidur tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga dan caregiver. Kebutuhan untuk merawat pasien pada malam hari sering kali menyebabkan gangguan tidur pada caregiver, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kelelahan, stres, serta gangguan kesehatan mental. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas perawatan yang diberikan, sehingga dalam pendekatan paliatif, perhatian terhadap kesejahteraan caregiver menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perawatan yang komprehensif.

Penatalaksanaan gangguan tidur dalam perawatan paliatif memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup intervensi non-farmakologis dan farmakologis. Pendekatan non-farmakologis meliputi pengaturan lingkungan tidur yang nyaman, pengurangan stimulasi berlebihan pada malam hari, serta pembentukan rutinitas tidur yang konsisten. Edukasi mengenai sleep hygiene, seperti membatasi tidur siang yang terlalu lama dan menghindari aktivitas yang merangsang sebelum tidur, juga dapat membantu memperbaiki kualitas tidur pasien.

Dalam kondisi tertentu, terapi farmakologis dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penatalaksanaan. Melatonin merupakan salah satu agen yang sering digunakan karena kemampuannya dalam mengatur ritme sirkadian dan memperbaiki kualitas tidur dengan profil efek samping yang relatif minimal. Selain itu, pada kasus gangguan tidur yang lebih berat, penggunaan obat sedatif seperti neuroleptik dapat dipertimbangkan, terutama jika disertai dengan gejala lain seperti agitasi atau delirium. Namun demikian, penggunaan obat-obatan ini harus dilakukan secara hati-hati dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan, mengingat pasien paliatif umumnya lebih rentan terhadap efek samping.

Pendekatan perawatan paliatif yang komprehensif juga perlu mencakup dukungan bagi keluarga dan caregiver, termasuk penyediaan layanan respite care atau bantuan perawatan pada malam hari. Hal ini penting untuk mengurangi beban fisik dan emosional caregiver serta menjaga keberlanjutan perawatan yang optimal bagi pasien.

Perawat memiliki peran penting dalam mengkaji pola tidur pasien, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur, serta memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan pendekatan yang holistik dan berpusat pada pasien, pengelolaan gangguan tidur diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, mengurangi distress, serta mendukung kualitas hidup pasien dan keluarga dalam perawatan paliatif.

10. Xerostomia (Mulut kering)

Xerostomia merupakan kondisi yang ditandai dengan sensasi subjektif berupa mulut kering, yang sering dialami oleh pasien dalam perawatan paliatif. Meskipun istilah ini kerap dikaitkan dengan disfungsi kelenjar ludah (salivary gland dysfunction), keduanya tidak sepenuhnya identik. Disfungsi kelenjar ludah

merujuk pada perubahan produksi saliva secara objektif, baik berupa penurunan maupun peningkatan, sedangkan xerostomia lebih menekankan pada persepsi subjektif pasien terhadap kekeringan rongga mulut. Dengan demikian, seorang pasien dapat mengalami xerostomia meskipun produksi saliva tidak selalu mengalami penurunan yang signifikan secara klinis.

Secara epidemiologis, xerostomia merupakan kondisi yang cukup umum di populasi umum, dengan prevalensi sekitar 20%. Angka ini meningkat pada kelompok tertentu, seperti wanita dan individu usia lanjut, serta jauh lebih tinggi pada pasien dengan penyakit kronis dan mengancam jiwa, khususnya kanker stadium lanjut. Pada pasien paliatif, xerostomia sering kali menjadi masalah yang signifikan karena dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makan, berbicara, dan kenyamanan umum.

Penyebab xerostomia pada pasien paliatif bersifat multifaktorial. Faktor penyebab yang sering ditemukan meliputi efek samping pengobatan, seperti opioid, antikolinergik, dan terapi kanker (kemoterapi maupun radioterapi), dehidrasi, serta kondisi sistemik yang memengaruhi fungsi kelenjar ludah. Selain itu, gangguan pernapasan melalui mulut dan kondisi umum pasien yang lemah juga dapat memperburuk sensasi mulut kering. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan xerostomia sebagai gejala yang kompleks dan membutuhkan pendekatan penanganan yang komprehensif.

Dampak xerostomia terhadap pasien tidak dapat diabaikan. Kekeringan rongga mulut dapat menyebabkan kesulitan menelan (disfagia), gangguan pengecap, serta meningkatkan risiko infeksi oral seperti kandidiasis. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman yang persisten dan mengganggu kualitas hidup pasien secara keseluruhan.

Penatalaksanaan xerostomia dalam perawatan paliatif berfokus pada peningkatan kenyamanan pasien dan pencegahan komplikasi. Perawatan mulut (oral care) merupakan intervensi utama yang harus dilakukan secara rutin. Menjaga kebersihan rongga mulut melalui penyikatan gigi secara teratur dan penggunaan larutan pembersih mulut yang lembut dapat membantu mengurangi risiko infeksi. Selain itu, penggunaan pelumas atau saliva buatan dapat membantu menjaga kelembapan rongga mulut dan mengurangi rasa kering.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan meliputi peningkatan asupan cairan jika memungkinkan, serta penggunaan permen bebas gula atau stimulan saliva untuk merangsang produksi air liur. Pada beberapa kasus, modifikasi terapi obat yang menjadi penyebab xerostomia juga dapat dipertimbangkan, dengan tetap memperhatikan kondisi klinis pasien secara keseluruhan.

Perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi gejala xerostomia sejak dini, memberikan edukasi mengenai perawatan mulut yang tepat, serta

memantau kondisi rongga mulut pasien secara berkala. Pendekatan yang holistik dan berpusat pada pasien sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penatalaksanaan xerostomia tidak hanya mengurangi gejala, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien dalam perawatan paliatif.

C. Penutup

Pengendalian gejala merupakan salah satu tujuan utama dalam perawatan paliatif, dengan fokus pada peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup pasien. Setiap individu memiliki pengalaman yang unik, sehingga gejala yang muncul pada fase akhir kehidupan dapat bervariasi, baik dari segi jenis, intensitas, maupun dampaknya. Gejala yang umum ditemukan meliputi nyeri, konstipasi, mual dan muntah, kelelahan, sesak napas, kelemahan, hingga delirium. Dalam praktiknya, sebagian besar gejala dapat dikelola hingga mencapai tingkat yang dapat ditoleransi melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Namun demikian, pada beberapa kondisi, gejala mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, pendekatan perawatan paliatif menekankan pada upaya pengurangan penderitaan secara optimal, dengan tetap menghargai martabat, kebutuhan, dan preferensi pasien serta dukungan bagi keluarga.

Referensi

- Better Health Channel. (n.d.). Palliative care – Dealing with common symptoms. Victorian State Government. <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/Palliative-care-dealing-with-common-symptoms>
- Cherny, N. I., & Fallon, M. (2021). Oxford textbook of palliative medicine (6th ed.). Oxford University Press.
- Davis, M. P., & Hallerberg, G. (2021). A systematic review of the treatment of nausea and vomiting in palliative care. *Journal of Pain and Symptom Management*, 61(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.07.036>
- Ferrell, B. R., Twaddle, M. L., Melnick, A., & Meier, D. E. (2020). National consensus project clinical practice guidelines for quality palliative care. *Journal of Pain and Symptom Management*, 60(5), 130–147. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.07.003>
- Hambali, F. H., Susdanarto, S., Utami, N. A. mi, N. A. S., Aminudin, M., & Lazuardi, N. (2024). Intervensi Spiritual Care untuk Menurunkan Insomnia pada Pasien yang Menjalani Hemodialisis. *ASJN (Aisyiyah Surakarta Journal of Nursing)*, 5(1), 33–39. <http://doi.org/10.30787/asjn.v5i1.1469>
- Hui, D., & Bruera, E. (2021). Models of integration of oncology and palliative care. *The Lancet Oncology*, 22(3), e77–e86. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(20\)30519-6](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30519-6)
- Inouye, S. K., Westendorp, R. G. J., & Saczynski, J. S. (2019). Delirium in elderly people. *The Lancet*, 383(9920), 911–922. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60688-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60688-1)
- Kelompok Pakar Perawatan Paliatif. (2016). *Pedoman Terapi : Perawatan Paliatif Versi 4*. Therapeutic Guidelines Limited, Melbourne.
- Leppert, W. (2019). The role of opioid receptor antagonists in the treatment of opioid-induced constipation: A review. *Advances in Therapy*, 36(1), 23–38. <https://doi.org/10.1007/s12325-018-0831-1>
- Mamnua, M., & Trihidayati, N. (2024). Palliative care pada pasien: Literature review.
- Munthe, L. A. M., Nurhayati, E. L., Sinaga, F.K.L, Pakpahan, C.J.R & (2023). Pengaruh Perawatan Paliatif Terhadap Kualitas Hidup Pasien yang Menjalani Terapi Hemodialisa di Ruang Hemodialisa di RSUD Royal Prima Medan. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3(4), 900–912.
- Nugraha, A. F., Mahmud, M., & Wisudarti, C. F. R. (2023). Penatalaksanaan paliatif pasien dengan nyeri kanker. *Jurnal Komplikasi Anestesi*, 4(1), 71–89.

- Radbruch, L., & Payne, S. (2020). White paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe. European Association for Palliative Care.
- Schacter, J., & Pilkey, J. (2025). Characterizing Difficulties and Management of Sleep Disturbances in a Tertiary Palliative Care Unit—A Retrospective Review. *Journal of Palliative Care*
- World Health Organization. (2019). WHO guidelines for the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). Palliative care. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>

BAB III

KOMUNIKASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN (ADVANCE CARE PLANNING, GOALS OF CARE, INFORMED CONSENT DAN PENYAMPAIAN KABAR SULIT)

A. Pendahuluan

Perawatan paliatif merupakan perawatan holistik bagi pasien yang mengalami penderitaan serius akibat penyakit parah yang dialami. Penyakit parah tersebut dapat bersifat akut maupun kronis dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Pasien dengan penyakit kronis mengalami beban penderitaan yang berdampak pada kualitas hidup dan fungsi peran pasien, serta menimbulkan beban tambahan seperti multiple gejala yang dirasakan pasien, penambahan proses pengobatan serta meningkatkan stres yang dirasakan pasien dan keluarga. Satu hal penting dalam perawatan paliatif ialah memfasilitasi dimulainya komunikasi terkait *end of life* (EOL). Komunikasi *end of life* (EOL) dilakukan dengan mengintegrasikan *advance care planning* sebagai upaya untuk menjamin kemandirian pasien dan meningkatkan kualitas masa-masa menjelang kematian. *Advance Care Planning* (ACP) melibatkan setiap pasien dalam menentukan tujuan dan preferensi pasien terkait perawatan dan pengobatan medis yang akan dilakukan, mendiskusikan terkait perawatan dan pengobatan medis dengan keluarga dan tenaga Kesehatan serta mendokumentasikan dan meninjau kembali tujuan dan preferensi di waktu yang tepat. Melalui *advance care planning* tidak kualitas hidup dan akhir hidup pasien meningkat, namun juga dapat membantu dalam memberikan perawatan paliatif yang efektif, kualitas hidup keluarga menjadi lebih baik, serta intervensi medis pada masa akhir kehidupan pasien berkurang.

B. Advance Care Planning

Perawatan paliatif merupakan proses pemberian perawatan kepada pasien dengan masalah kesehatan yang serius dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, menghilangkan penderitaan yang dihadapi secara fisik, psikologis, emosional maupun spiritual pasien dan keluarga (Mursid et al., 2024). Pasien dengan perawatan paliatif membutuhkan *advance care planning* sebagai upaya menjamin

otonomi serta meningkatkan kualitas akhir hidup pasien melalui diskusi untuk menggali pemahaman pasien mengenai kondisi penyakit, preferensi pengobatan, dan tujuan perawatan melalui pengambilan keputusan bersama (Goswami, 2021; Lee et al., 2024).

Advance Care Planning (ACP) merupakan suatu proses yang melibatkan pasien untuk (1) merenungkan nilai dan tujuan perawatan, (2) mendiskusikan terkait nilai dan tujuan dengan orang lain, dan (3) mendokumentasikan pilihan pasien. (Harding et al., 2023). *Advance Care Planning* tidak hanya melibatkan pasien namun juga anggota keluarga, *care giver* (pengasuh), dan tenaga kesehatan untuk memahami, meninjau, dan merencanakan keputusan perawatan kesehatan yang akan dilakukan. *Advance Care Planning* mendorong pengambilan Keputusan Bersama sesuai dengan nilai dan preferensi pasien terkait perawatan medis termasuk penunjukan wakil pengambil keputusan sebelum terjadinya krisis medis atau hilangnya kemampuan pasien untuk mengambil Keputusan (Goswami, 2021).

C. Tujuan Advance Care Planning

Pelaksanaan *Advance Care Planning* bertujuan untuk; (Lee et al., 2024)

1. Meningkatkan kualitas komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, khususnya dalam menyampaikan preferensi pengobatan
2. Mengurangi konflik dalam pengambilan keputusan
3. Memperkuat kesepakatan mengenai preferensi antara pasien dan tenaga kesehatan
4. Meningkatkan pendokumentasian preferensi

D. Manfaat Advance Care Planning

Pelaksanaan *Advance Care Planning* memiliki manfaat seperti (Goswami, 2021);

1. Meningkatkan kualitas komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan,
2. Peningkatan otonomi pasien,
3. Pengurangan perawatan yang tidak diinginkan dan tidak perlu,
4. Pengurangan lama dan jumlah rawat inap
5. Tindakan ventilasi, resusitasi, dan rawat inap di unit perawatan intensif berkurang
6. Peningkatan penggunaan perawatan paliatif dengan pendaftaran dini di rumah sakit paliatif
7. Penurunan biaya perawatan pada akhir hayat
8. Konflik pengambilan keputusan diantara pihak yang mewakili pasien berkurang
9. Tempat meninggal dapat ditentukan berdasarkan preferensi pasien menjelang akhir hidup

E. Isi Advance Care Planning

Advance Care Planning mencakup beberapa hal sebagai berikut; (Goswami, 2021)

1. Surat kuasa medis (pihak yang berwenang mengambil keputusan atas nama pasien),
2. Surat wasiat hidup (yang memuat keinginan pasien terkait resusitasi kardiopulmoner, ventilasi mekanis, pemberian makan melalui selang, dan dialisis pada akhir hayat)
3. Dokumen larangan resusitasi di luar rumah sakit

F. Faktor Pelaksanaan Advance Care Planning

Pelaksanaan *Advance Care Planning* (ACP) sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi faktor yang menghambat, seperti berikut (Goswami, 2021; Lee et al., 2024).

1. Budaya

Budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *advance care planning*, sebagai contoh di benua asia yang menenankan nilai tradisional dengan menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dalam perawatan medis pasien. Konfusianisme sabagi salah satu konsep yang mengedapankan konsep “kebaktian anak kepada orang tua” yang menekankan kewajiban anak untuk melindungi orang tua dari kabar buruk terutama yang berkaitan dengan kematian. Olehkarenanya anggota keluarga di seluruh negaa di benua asia seringkali mengesampingkan preferensi pasien dalam membahas akhir hayat.

Hal ini berbeda dengan budaya yang berada di Negara Barat yang menekankan pendekatan berpusat pada pasien dan keluarga. Pendekatan ini menekankan peran penting keterlibatan keluarga dalam mendukung partisipasi pasien dalam *advance care planning*, dan memastikan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan terbaik bagi pasien melalui pengambilan keputusan bersama.

2. Diskusi terkait kematian masih merupakan hal yang tabu
3. Rasa tidak nyaman dalam melakukan diskusi yang sulit
4. Sosial dimana masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang *advance care planning*, kekhawatiran akan terjadinya konflik dengan keluarga pasien dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
5. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan khususnya dalam mengenali prognosis yang buruk sebagai penanda tahap akhir hidup pasien
6. Kekhawatiran mengenai kesiapan emosional pasien dan keluarga untuk membahas acp. Tenaga kesehatan menganggap waktu yang tepat untuk

memulai pembicaraan tentang acp adalah ketika harapan hidup pasien kurang dari enam bulan atau ketika pasien yang menderita penyakit serius dirawat di rumah sakit. Penentuan harapan hidup pasien memerlukan konfirmasi dari setidaknya dua dokter, termasuk satu dokter spesialis.

7. Kurangnya sistem yang terstandarisasi dan dukungan pemerintah untuk pelaksanaan acp.
8. Kurangnya waktu,
9. Ketidaknyamanan pribadi terhadap kematian dan proses meninggal
10. Keengganan untuk menyampaikan informasi yang menyakitkan
11. Persepsi tentang kegagalan dokter lain, terlalu fokus pada penyembuhan atau pengobatan,
12. Kurangnya pengalaman dalam menyampaikan berita akhir hayat
13. Kurangnya bimbingan dalam mempraktikkan strategi komunikasi mengenai akhir hayat.

G. Cara Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Advance Care Planning

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam upaya pelaksanaan *advance care planning*, sebagai berikut; (Lee et al., 2024)

1. Diskusi terbuka mengenai kematian dan proses menjelang kematian yang didukung oleh pendidikan masyarakat dengan penyediaan alokasi waktu khusus untuk diskusi ACP
2. Mempromosikan ACP melalui situs web, media massa, publikasi, dan brosur. Pembahasan mengenai ACP muncul secara implisit dalam drama, film, dan media sosial.
3. Pembentukan sistem hukum dan terstandarisasi, serta dukungan kelembagaan bagi ACP
4. Pelatihan dan pendidikan komprehensif bagi tenaga kesehatan,
5. Dukungan untuk mengatasi kelelahan dan tekanan moral yang mungkin dihadapi oleh tenaga kesehatan selama proses ACP

H. Strategi Efektif Pelaksanaan Advance Care Planning

Pelaksanaan *advance care planning* mencakup beberapa konsep penting, yakni sebagai berikut; (Lee et al., 2024)

1. Menilai kesiapan pasien dan keluarga untuk diskusi terkait hal penting dan mengidentifikasi hambatan
2. Menunjuk seorang pengambil keputusan pengganti (kuasa medis)
3. Mengeksplorasi pemahaman pasien dan keluarga mengenai status penyakit dan pilihan pengobatan,

4. Mendiskusikan nilai-nilai, tujuan perawatan, dan pilihan perawatan di akhir hayat,
5. Mendokumentasikan preferensi pasien dalam rekam medis,
6. Meninjau kembali pembicaraan tersebut pada setiap perubahan rencana pengobatan dan/atau perubahan status klinis termasuk pada setiap rawat inap.

**Tabel 2.1 Strategi dalam pelaksanaan ACP dan komunikasi akhir hayat
(*end of life*) (Goswami, 2021)**

Intervensi	Deskripsi
Pelatihan tenaga kesehatan	Pelatihan keterampilan komunikasi
Mengidentifikasi pasien yang berisiko	a. Pasien dengan penyakit yang terus memburuk b. Pasien yang tidak memiliki kerabat terdekat atau yang tinggal sendirian
Memulai komunikasi sebelum kondisi pasien semakin memburuk	a. Tentukan waktu yang tepat dengan kriteria 1. Perkembangan penyakit 2. Perubahan pengobatan 3. Efek samping pengobatan 4. Meningkatnya beban gejala b. Jadwalkan kunjungan terpisah
Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga	a. Memulai diskusi sebelum keputusan diambil b. Berikan informasi yang sesuai mengenai prognosis berdasarkan preferensi informasi c. Fokus pada tujuan dan nilai-nilai terkait perawatan d. Mulai diskusi mengenai tujuan non-medis e. Menginisiasi keluarga dan pasien untuk merenungkan dan memperjelas keinginan keluarga dan pasien melalui diskusi secara berkelanjutan
Gunakan daftar panduan percakapan	a. Pemahaman: Bagaimana pemahaman Anda mengenai penyakit Anda? b. Preferensi informasi: Seberapa banyak informasi yang Anda inginkan dari saya mengenai penyakit Anda? c. Prognosis: Sampaikan prognosis yang disesuaikan dengan preferensi informasi Anda

	d. Tujuan: Apa tujuan terpenting Anda jika kondisi kesehatan Anda memburuk? e. Ketakutan/kekhawatiran: Apa ketakutan dan kekhawatiran terbesar Anda mengenai masa depan kesehatan Anda? f. Fungsi: Kemampuan apa yang sangat penting bagi hidup Anda sehingga Anda tidak bisa membayangkan hidup tanpa itu? g. Kompromi: Jika kondisi Anda memburuk, seberapa besar Anda bersedia mengorbankan sesuatu demi kemungkinan mendapatkan waktu lebih lama? h. Keluarga: Seberapa banyak keluarga Anda mengetahui tentang prioritas dan keinginan Anda?
Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam menyampaikan informasi penting terkait rekam medis elektronik	a. Pastikan bahwa rekam medis elektronik sebagai "sumber informasi tunggal yang dapat diandalkan" untuk mencatat dan mengakses nilai-nilai, tujuan, dan preferensi perawatan pasien serta informasi penting lainnya b. Wali kesehatan c. Medical order for life-sustaining treatments d. Kode status
Mengukur dan melaporkan kinerja	Menyusun standar kinerja yang sesuai

I. Goals of Care

Goals of care berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai aspek-aspek perawatan klinis yang lebih luas, dibandingkan dengan sub-tema medis yang lebih spesifik yang berfokus pada intervensi klinis individual. *Goals of care* mencakup dilema terkait tujuan dan pelaksanaan perawatan, khususnya pengambilan keputusan klinis yang beralih dari pengobatan menjadi pengelolaan gejala, penghentian dan penundaan pengobatan, proporsionalitas pengobatan, penilaian terhadap efek pengobatan, serta tempat perawatan dan kematian yang diinginkan oleh pasien (Schofield et al., 2021).

J. Informed Consent

Perawatan paliatif sebagai salah satu perawatan yang kompleks bagi pasien dengan kronis sering menghadapi berbagai tantangan atau menimbulkan masalah etik salah satunya ialah *informed consent* atau persetujuan (Ibrahim et al., 2024). *Informed consent* merupakan bagian penting dalam menerapkan prinsip menghormati otonomi pasien, dan pasien umumnya diakui sebagai pihak utama yang harus memberikan persetujuan (Kriekemans et al., 2025).

K. Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk

Perawatan paliatif adalah jenis perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga pasien. Namun, sebelum mencapai tahap ini, penyampaian kabar buruk menjadi hal yang penting saat memberikan informasi mengenai penyakit tersebut. Berita buruk didefinisikan sebagai berita mengenai suatu keadaan yang tidak memberikan harapan dan mengancam kesejahteraan mental atau fisik seseorang (Aydin et al., 2020).

Penyampaian kabar buruk kepada pasien dan keluarga merupakan situasi yang sangat sulit bagi pasien maupun keluarganya. (Aydin et al., 2020). Penyampaian kabar buruk mengacu pada tindakan menyampaikan atau mengkomunikasikan kabar buruk kepada pasien atau keluarga terdekat (Ayalew et al., 2023). Secara umum, saat menyampaikan kabar buruk, diagnosis medis disampaikan kepada pasien termasuk informasi tentang diagnosis kronis baru atau perburukan kondisi penyakit kronis. Menyampaikan kabar buruk dapat bersifat subjektif, sehingga sulit untuk memprediksi dampak dan konsekuensi yang dialami pasien dan keluarga akibat informasi kabar buruk tersebut (Aydin et al., 2020).

Penyampaian kabar buruk (*breaking bad news*) dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti (Ayalew et al., 2023; Mailankody et al., 2023; Traboulsi et al., 2025);

1. Metode SPIKES.

Metode SPIKES terdiri dari 6 tahap yakni *SETTING UP the Interview* (Menyiapkan wawancara), menilai *Perception of the patient* (persepsi pasien), Invitation (menunggu inisiatif atau kesediaan pasien untuk menyampaikan kabar tersebut), memberikan *Knowledge* (informasi) kepada pasien, menunjukkan empati terhadap *Emotions* (perasaan pasien), dan *Strategy /summary* (merangkum sesi). Protokol SPIKES merekomendasikan untuk menentukan kondisi fisik dan situasi lainnya, melakukan penilaian terhadap persepsi, menanyakan apakah pasien menginginkannya atau tidak serta sejauh mana informasi yang dibutuhkan, memberikan penjelasan, dan merangkum percakapan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait metode SPIKES;

a. Setting

nama lain dari setting ialah "start off well" (memulai dengan persiapan yang baik). tenaga kesehatan perlu memikirkan bagaimana, kapan, dimana dan dengan siapa kabar buruk akan disampaikan. pastikan bahwa terdapat waktu yang cukup untuk menyampaikan berita buruk, memilih ruangan yang terprivasi, dan pastikan siapa yang akan menemani pasien saat berita buruk disampaikan. Jika memungkinkan, sebaiknya informasi tidak disampaikan saat berdiri atau melalui telepon. melainkan duduk di ruangan yang tenang dan menyediakan cukup tempat duduk bagi pasien dan keluarga. perhatikan pada sumber distraksi yang memungkinkan mengganggu proses penyampaian berita buruk seperti telepon dan televisi yang harus dimatikan jika sedang menyala. Lakukan kontak mata saat berbicara sebagai wujud empati kepada pasien.

Empati juga dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan dasar untuk menggali kondisi psikologis pasien. Metode ABC dapat digunakan untuk menggali kondisi emosi pasien. metode ABC terdiri dari *Affect/appearance* "tampilan" yakni apakah pasien menunjukkan sikap atau ekspresi wajah? *Behaviour* "tingkah laku" yakni bagaimana Bahasa tubuh pasien dan pola komunikasi pasien? *Coping* "mengatasi" yakni apakah ada petunjuk lain yang memberitahu bagaimana pasien mengatasi kondisi pasien sekarang? jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kita dapat bertanya dengan pertanyaan mudah seperti "bagaimana perasaan Anda hari ini?", atau "Apakah anda siap untuk berbincang atau ngobrol sebentar?" dan terakhir ajak orang lain yang sekarang berada dengan pasien untuk ikut dalam diskusi.

Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah singkat pelaksanaan step *setting* wawancara, yakni;

- 1) Sediakan ruang yang tenang
- 2) Libatkan orang-orang terdekat sesuai pilihan pasien
- 3) Duduk
- 4) Bangun hubungan dengan pasien dengan menjaga kontak mata dan/atau sentuh pasien (jika ia merasa nyaman dengan hal tersebut)
- 5) Atur batasan waktu dan gangguan

b. *Perception*

Pasien dan keluarga berusaha memahami dan mencari informasi mengenai kondisi penyakit pasien. dalam hal ini untuk memastikan pemahaman pasien dan keluarga terkait kondisi pasien, petugas kesehatan dapat menggunakan metode "Before you tell, ASK". metode "Before you tell, ASK" memberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang pasien dan keluarga tahu terkait

kondisi kesehatan ataupun pengobatan yang akan dijalani pasien serta, mengetahui riwayat kesehatan pasien terdahulu. dengan menggunakan metode "Before you tell, ASK" pada step *perception*, petugas kesehatan dapat menentukan apa yang pasien pikirkan tentang dampak dari berita buruk bagi pasien dan keluarga kedepannya dan mengetahui apa yang menjadi fokus atau prioritas pasien dan keluarga.

Apa yang akan ditanyakan akan sangat tergantung dari kondisi, seperti pasien yang ingin mengetahui hasil pemeriksaan atau diagnosa penyakitnya, maka petugas kesehatan dapat mengajukan pertanyaan "bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut?". Disisi lain, ketika ini merupakan pertemuan yang pertama dengan pasien, maka Anda dapat bertanya "Apa yang telah diberitahukan kepada Anda mengapa pemeriksaan ini direkomendasikan? atau "Apa yang Anda ketahui terkait pertemuan kita pada hari ini?". Seyogiyanya jika Anda tidak familiar dengan pasien, maka pilih kalimat dengan hati-hati dan dengarkan secara seksama terhadap setiap respon emosi verbal atau nonverbal dan pemahaman pasien terkait penyakitnya.

Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah singkat pelaksanaan step mengkaji *perception* pasien, yakni;

- 1) Cari tahu apa yang diketahui pasien tentang kondisi medisnya atau apa yang pasien duga
- 2) Perhatikan tingkat pemahaman pasien
- 3) Cari tahu apakah pasien sedang menyangkal penyakitnya

c. *Invitation*

Invitation dilakukan dengan mengundang preferensi atau pengetahuan pasien ke dalam diskusi dan mengkaji seberapa besar pasien ingin tahu. Dengan menanyakan pasien terkait apa dan seberapa besar pasien ingin tahu akan membuat pasien mampu untuk menyiapkan berbagai hal sebagai upaya terhadap informasi berita buruk. Namun disisi lain, ketika informasi yang disampaikan merupakan informasi yang penting atau perlu diketahui oleh pasien maka petugas kesehatan dapat menyampaikan informasi tersebut lebih awal. Saat memberikan informasi, sebaiknya diucapkan dengan perlahan dan tanpa menggunakan istilah teknis agar pasien dan keluarga dapat memahami. Jika harus menggunakan istilah medis, istilah medis tersebut harus disampaikan sejelas mungkin.

Jika saat menyampaikan informasi, pasien menunjukkan sikap menolak, maka petugas kesehatan dapat menyimpan hal yang ingin disampaikan nanti dan menampung prefrensi pasien. Petugas kesehatan juga dapat meninggalkan

informasi kontak petugas kesehatan atau mengatur jadwal pertemuan selanjutnya baik melalui pertemuan secara tatap muka atau melalui panggilan telpon. disisi lain, Ketika waktu dalam menyampaikan berita buruk sedikit, lakukan dengan pendekatan sederhana karena pasien mungkin akan sulit memahami apa yang akan disampaikan. Petugas kesehatan dapat berdiskusi kembali dengan pasien di lain waktu dengan bertanya secara lebih detail untuk meyakinkan bahwa pasien telah memahami diskusi yang telah dilakukan.

Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah singkat pelaksanaan step *invitation*, yakni;

- 1) Tanyakan kepada pasien apakah pasien ingin mengetahui rincian mengenai kondisi medis dan/atau pengobatan
- 2) Hormati hak pasien untuk tidak mengetahuinya
- 3) Tawarkan untuk menjawab pertanyaannya nanti jika pasien menginginkannya

d. Knowledge

Step knowledge dilakukan dengan memberikan informasi kepada pasien. Informasi sebaiknya disampaikan dengan suara serendah mungkin dan dengan nada yang sesuai dengan situasi. Pasien dan/atau keluarganya harus ditanggapi dengan empati. pemberian informasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti;

- 1) Ulangi apa yang pasien katakan dengan meringkas atau menuliskan apa yang telah kita ketahui terkait kondisi psikologis atau tingkat pengetahuan pasien sebagai contoh "saya tahu bahwa sudah lama Anda ingin tahu kondisi, dan nampaknya Anda terlihat cemas untuk mengetahui hasil pemeriksaan Anda".
- 2) Perhatikan tanda peringatan dengan memberikan pasien jeda beberapa waktu untuk menyangga berita buruk. Anda dapat memulai menyampaikan berita buruk dengan kalimat "saya punya kabar yang mungkin Anda tidak sangka/duga", "saya mohon maaf karena harus memberitahu bahwa ...", "mohon maaf, hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan".
- 3) Menyampaikan berita buruk dengan mengawali secara sederhana, menyatakan secara langsung, atau membagi informasi menjadi bagian kecil. Anda dapat menyampaikan dengan menggunakan 2-3 kalimat. dan jika memungkinkan gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa pasien serta mengecek kembali pemahaman pasien jika diperlukan.
- 4) Berhenti sejenak untuk memberikan ruang bagi pasien untuk menangis dan menghindari pembicaraan yang tidak menyenangkan. berikan pasien ruang untuk mengekspresikan reaksi dan perasaan serta ruang untuk bertanya.

dan waktu ini juga menjadi waktu yang tepat bagi tenaga kesehatan untuk menilai emosi.

Satu hal penting dalam berbagi informasi dan merupakan hal terbaik bagi pasien ialah bersikap atau berkata jujur, langsung kepada inti dan realistis Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah singkat pelaksanaan step *knowledge* yakni;

- 1) Beritahukan kepada pasien bahwa ada kabar buruk yang akan disampaikan; hal ini dapat mengurangi keterkejutan yang mungkin timbul setelah kabar buruk tersebut diungkapkan
- 2) Sesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kosakata pasien
- 3) Gunakan kata-kata yang tidak terlalu teknis
- 4) Hindari bersikap terlalu blak-blakan
- 5) Sampaikan informasi secara bertahap, dan sesekali pastikan pasien memahaminya
- 6) Hindari menggunakan ungkapan seperti "Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan untuk Anda"

e. Emotions / Exploring / Empathy

Emosi dan respon pasien terhadap berita buruk dapat ditunjukkan dengan berbagai cara seperti menyangkal, tidak percaya, cemas, sedih, putus asa, shock, takut, tidak berdaya, menyalahkan diri dengan mengatakan "saya melakukan hal yang salah atau memalukan" atau "saya orang jahat". saat Ketika pasien mempunyai waktu untuk mengekspresikan perasaan, petugas kesehatan dapat merespon dengan menunjukkan sikap empati dan meluangkan waktu sejenak untuk menggali perasaan, kepercayaan, motivasi dan sikap yang akan ditunjukkan pasien saat mendengarkan berita buruk.

Tunjukkan empati dengan mengidentifikasi emosi pasien dan memahami emosi yang dirasakan pasien dengan menyatakan "Apa yang membuat berita buruk menjadi buruk?". Tunjukkan empati dengan kalimat seperti "Saya tahu berita ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan", "mendengar berita ini pasti akan membuat kita sedih", "Saya tahu ini sangat mengejutkan". sebagai tambahan, validasi emosi pasien sebagai hal yang normal dengan mengatakan "saya mengerti kenapa Anda berpikir seperti itu".

Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah singkat pelaksanaan step *emotion with emphatic responses* yakni;

- 1) Perhatikan apakah ada emosi yang ditunjukkan oleh pasien
- 2) Identifikasi emosi yang dialami pasien dengan menyebutkannya dalam hati
- 3) Identifikasi penyebab emosi tersebut

- 4) Beri tahu pasien bahwa Anda telah mengaitkan emosi tersebut dengan penyebabnya dengan menyampaikan pernyataan yang menghubungkan keduanya

f. Summary / Strategy

Siapkan informasi dan strategi terkait apa yang akan dilakukan atau informasi apa yang diberikan berikutnya. Seperti "Apa dampak kabar buruk kepada pasien dan keluarga? "Apakah ada keputusan yang mendesak?", Apa informasi yang pasien dan keluarga ini tahu. Pada tahap ini, sangat penting bagi petugas kesehatan untuk menjawab setiap pertanyaan dan menyediakan jaminan pelayan atau informasi terkait kondisi kesehatan atau penyakit pasien dan bekerjasama dengan pasien untuk menyusun rencana. Perhatikan terhadap sikap pasien yang takut atau malu bertanya, dan ketika pasien merasa terbebani mendiskusikan berita buruk maka Anda dapat tidak memberitahukan secara lebih kompleks, namun hanya pada poin penting saja untuk memastikan bahwa pasien telah memahami apa yang didiskusikan dan dapat memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang telah dibicarakan sebaiknya dirangkum secara singkat. Tanggal pertemuan berikutnya dan proses penanganan sebaiknya dibahas.

Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah singkat pelaksanaan step Strategy and summary. Rangkum informasi yang telah Anda sampaikan. Jika pasien sudah siap, bahas rencana perawatan

- 1) Berbagi tanggung jawab dalam pengambilan Keputusan
- 2) Pastikan pasien memahami atau tidak memahami pembahasan

2. Metode P-SPIKES

Metode ini merupakan modifikasi dari metode SPIKES yang muncul di tahun 2005, dimana "P" untuk "Preparation" yang berarti meninjau semua informasi mengenai pasien yang perlu disampaikan dan melatih pasien jika diperlukan. Kritik lain terhadap protokol ini adalah tidak adanya langkah yang mengatur pertanyaan dan klarifikasi dari pasien (Kumar & Sarkhel, 2023).

3. Metode SPwICES

Metode SPwICES mencakup "w" yang secara khusus membahas "*warning shot*" ("tembakkan peringatan") dan "ICE" yang melibatkan upaya menyeimbangkan antara memberikan informasi, memberikan klarifikasi, dan menangani emosi (Kumar & Sarkhel, 2023).

4. Metode BREAKS

BREAKS adalah protokol lain yang merupakan singkatan dari *Background* (Latar Belakang), *Rapport* (Hubungan), *Explore* (Eksplorasi) *Announce*

(Pengumuman), *Kindle* (Membangkitkan), dan *Summarize* (Ringkasan). Berikut penjelasan lebih lanjut terkait metode BREAKS;

a. Latar Belakang

Sebelum menyampaikan kabar buruk, perlu dilakukan studi mendalam mengenai kondisi penyakit pasien, kondisi emosional, kemampuan mengatasi masalah, tingkat pendidikan, dan sistem dukungan

b. Hubungan

Membangun hubungan yang baik dengan menunjukkan sikap positif dan mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka.

c. Ekplorasi

Petugas kesehatan dapat memulai dengan menanyakan apa yang pasien ketahui mengenai penyakitnya

d. Pengumuman

- 1) Sebaiknya diberikan peringatan "warning shot" terlebih dahulu
- 2) Sampaikan informasi dalam kalimat-kalimat singkat dan mudah dipahami
- 3) Sebaiknya jangan memberikan lebih dari tiga informasi sekaligus

e. Membangkitkan

Berikan ruang yang cukup untuk mengalirnya emosi secara bebas. Pastikan pasien/keluarga tidak salah memahami tingkat keparahan penyakit

f. Ringkasan

Petugas kesehatan harus merangkum sesi pertemuan dan mendiskusikan rencana pengobatan.

5. Metode ABCDE

Metode ABCDE, yang merupakan salah satu metode untuk menyampaikan kabar buruk kepada keluarga dengan cara yang. metode ABCDE menekankan bahwa informasi sebaiknya diberikan di lingkungan yang tenang, misalnya di ruang praktik, dan pada waktu yang tepat. Informasi harus disampaikan dengan waktu yang cukup, dan jawaban yang jelas harus diberikan atas pertanyaan yang diajukan.

Metode ABCDE mencakup *Advance preparation* (Persiapan awal), *Building a therapeutic relationship* (Membangun hubungan terapeutik), *good Communication* (berkomunikasi dengan baik), *Dealing with reactions* (Menangani reaksi), dan *Encouraging emotions* (Mendorong dan mengakui emosi).

Kumar & Sarkhel (2023) secara lebih ringkas menuliskan langkah dalam pelaksanaan metode ABCDE, sebagai berikut;

a. Persiapan awal

- 1) Tanyakan apa yang sudah diketahui dan dipahami oleh pasien.
- 2) Bagaimana coping pasien?

- 3) Pastikan ada orang yang dapat atau anggota keluarga yang tepat yang dapat memberikan dukungan
 - 4) Tentukan waktu dan tempat yang tidak akan terganggu
 - 5) Persiapkan diri secara emosional
 - 6) Tentukan kata-kata dan frasa yang akan digunakan (tuliskan naskah)
 - 7) Latih cara menyampaikan berita
- b. Bangun lingkungan/hubungan terapeutik
- 1) Siapkan tempat yang privat dan tenang tanpa gangguan
 - 2) Sediakan tempat duduk yang memadai untuk semua
 - 3) Atur jarak tempat duduk agar jarak duduk cukup dekat untuk menyentuh jika memungkinkan
 - 4) Tenangkan kekhawatiran tentang rasa sakit, penderitaan, dan rasa ditinggalkan
- c. Berkomunikasi dengan baik
- 1) Bicara secara langsung ("Maaf, saya punya kabar buruk")
 - 2) Jangan gunakan eufemisme, jargon, atau akronim. Katakan "kanker" atau "kematian"
 - 3) Biarkan ada keheningan
 - 4) Gunakan sentuhan secara tepat
- d. *Dealing with reactions* dengan meminta pasien untuk mengulang pemahaman pasien tentang berita buruk
- 1) Atur pertemuan lanjutan
 - 2) Gunakan pengulangan dan penjelasan tertulis atau pengingat
 - 3) Tangani reaksi pasien dan keluarga
 - 4) Evaluasi reaksi pasien seperti;
 - a) Respons fisiologis: lari/melawan, konservasi/penarikan diri
 - b) Strategi koping kognitif: penyangkalan, menyalahkan, intelektualisasi, ketidakpercayaan, penerimaan
 - c) Respons afektif: kemarahan/amarah, ketakutan/teror, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, rasa malu, kelegaan, rasa bersalah, kesedihan, duka antisipatif dengan mendengarkan secara aktif, jelajahi perasaan serta ungkapkan empati
- e. Dorong dan akui emosi (cerminkan kembali emosi) dengan
- 1) Koreksi distorsi. Tawarkan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain atas nama pasien
 - 2) Evaluasi dampak berita tersebut
 - 3) Telusuri arti berita buruk bagi pasien

- 4) Tanggapi kebutuhan lebih lanjut, tentukan rencana jangka pendek dan menengah pasien,
- 5) Nilai risiko bunuh diri. Lakukan rujukan yang sesuai untuk dukungan lebih lanjut. Berikan materi tertulis
- 6) Atur tindak lanjut
- 7) Proses perasaan Anda sendiri.

6. Metode PENS

Pendekatan PENS didasarkan pada prinsip dasar otonomi pasien karena langkah pertama adalah menggali preferensi pasien "*Patient preference*" terkait *breaking bad news*, selanjutnya "*Explanation*" penjelasan mengenai kondisi penyakit, penjadwalan pertemuan berikutnya "*scheduling the Next appointment*", serta pemberian dukungan "*Support*" kepada pasien.

Pendekatan PENS menyarankan agar hanya menyampaikan informasi dasar yang diperlukan pada kunjungan pertama, sehingga membantu pasien menyerap informasi dengan lebih baik dan mengambil keputusan penting terkait pengobatan awal. Dengan demikian, seluruh sesi "pemberian informasi" dapat dibagi menjadi beberapa sesi. Seiring pasien menjadi lebih nyaman melalui diskusi berulang, pasien/keluarga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan relevan lainnya, meskipun membutuhkan kunjungan kedua dalam waktu singkat untuk diskusi yang lebih lanjut.

7. Model Kaye's 10 step

Model Kaye's 10 step terdiri dari beberapa langkah, yakni; (Kumar & Sarkhel, 2023).

- a. Persiapan
 - 1) Ketahui semua fakta
 - 2) Pastikan privasi terjaga
 - 3) Cari tahu siapa saja yang ingin dihadirkan oleh pasien
 - 4) Perkenalkan diri Anda
- b. Cari tahu apa yang sudah diketahui pasien
 - 1) Mulailah dengan pertanyaan terbuka (misalnya, "Bagaimana semuanya dimulai?")
- c. Tentukan apakah pasien menginginkan informasi lebih lanjut
 - 1) Jangan memaksa pasien untuk menerima informasi (misalnya, "Apakah Anda ingin saya menjelaskannya sedikit lebih lanjut?")
- d. Berikan peringatan
 - 1) Jangan langsung ke intinya! (misalnya, "Saya khawatir ini terlihat cukup serius")
- e. Izinkan pasien untuk menolak informasi pada saat itu

- 1) Penolakan adalah mekanisme pertahanan dan cara mengatasi
- 2) Biarkan pasien mengontrol jumlah informasi yang diterimanya
- f. Jelaskan jika diminta
 - 1) Lakukan secara bertahap
 - 2) Penjelasan Anda mungkin tidak diingat, tetapi cara Anda menjelaskannya akan diingat
- g. Dengarkan kekhawatiran
 - 1) Tanyakan "Apa kekhawatiran Anda saat ini?"
 - 2) Berikan waktu dan ruang untuk memikirkan jawaban
- h. Dorong ekspresi perasaan
 - 1) Akui perasaan tersebut
 - 2) Jangan menghakimi
- i. Rangkum
 - 1) Tinjau kekhawatiran dan rencana pengobatan
 - 2) Bangun harapan
 - 3) Berikan informasi tertulis jika diminta
- j. Lakukan tindak lanjut
 - 1) Berikan informasi tambahan
 - 2) Pastikan pasien bahwa Anda selalu siap membantu

8. Metode PWETER

Metode PWETER terdiri dari (Kumar & Sarkhel, 2023).

- a. P "*preparing*" yakni mempersiapkan pemberi kabar melalui pendidikan dan pelatihan, serta mempersiapkan suasana dan pendekatan dalam menyampaikan kabar
- b. E "*evaluating*" yakni mengevaluasi apa yang sudah diketahui oleh pendengar
- c. W "*warning*" yakni memberi peringatan dengan menyampaikan pernyataan singkat yang diikuti dengan jeda sejenak untuk mempersiapkan pendengar menghadapi kabar buruk yang akan disampaikan selanjutnya
- d. T "*telling*" yakni memberitahukan berita buruk
- e. E "*emotional response*" yakni memperhatikan dan merespons secara tepat terhadap respons emosional pendengar
- f. R "*regrouping*" yakni pemulihan dengan membantu pendengar melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya.

9. Metode ARCHES

Metode ARCHES bertujuan untuk memudahkan komunikasi ketika keluarga meminta agar diagnosis tidak diungkapkan, meskipun pasien telah memberikan persetujuan untuk mengetahui kondisi yang dialami. Metode ARCHES digunakan sebelum menggunakan metode SPIKES dimana keluarga meminta agar diagnosis

tidak diungkapkan. Metode ARCHES dapat memberikan strategi untuk menghargai sudut pandang keluarga, menegaskan niat baik keluarga, dan mengoreksi kesalahpahaman (Holmes & Illing, 2021). Metode ARCHES mencakup yakni sebagai berikut;

- a. *A - Acknowledge the request for non-disclosure* (Menyadari permintaan untuk tidak mengungkapkan informasi).

Salah satu hambatan utama dalam menangani masalah ketidakterbukaan informasi diagnostik adalah bahwa dilema ini sering kali tidak diungkapkan. Ketidakterbukaan informasi dapat terjadi secara otomatis, tanpa pertimbangan yang disadari sehingga dibutuhkan strategi yang menekankan perlunya menangani masalah ini secara langsung.

- b. *R - Build the Relationship between the clinician and the family, clarifying values* (Membangun hubungan antara tenaga medis dan keluarga, serta memperjelas nilai-nilai yang dianut).

Saling pengertian merupakan kunci kerja sama. Tenaga kesehatan perlu memahami kekhawatiran keluarga agar dapat menenangkan keluarga, menghargai nilai dan karakteristik pribadi pasien agar menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, serta mendengarkan secara aktif dan berupaya untuk memahami secara lebih mendalam untuk membangun kepercayaan pasien dan keluarga.

- c. *C - Find Common ground* (Menemukan titik temu)

Setelah saling memahami sudut pandang masing-masing, tenaga kesehatan perlu mengidentifikasi tujuan dan nilai-nilai bersama. Saat menghadapi dilema budaya, maka perlu untuk mencari titik temu, sebagai contoh titik temu antara tenaga kesehatan-pasien-keluarga yakni mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik pasien serta menjaga hubungan keluarga yang harmonis.

- d. *H - Honour the patient's information preferences; outline Harm of non-disclosure* (Menghormati preferensi pasien terkait informasi; menjelaskan risiko jika informasi tidak diungkapkan)

Setelah memahami posisi keluarga, tenaga kesehatan dapat melanjutkan dengan menyadarkan keluarga tentang manfaat memberi tahu pasien serta pentingnya menghormati preferensi pasien terkait informasi, disamping risiko yang dapat menimpa pasien dan beban yang ditanggung keluarga jika informasi tersebut tidak diungkapkan.

- e. *E - Provide Emotional support and respond to concerns* (Memberikan dukungan emosional dan menanggapi kekhawatiran)

Tenaga kesehatan perlu meyakinkan keluarga bahwa penyampaian berita buruk akan dilakukan dengan penuh empati. Pasien tidak akan dipaksa untuk

mendengarkan berita buruk, melainkan hanya akan diberi tahu. Pasien selalu dapat memilih untuk tidak mengetahui diagnosis pasien sendiri dan izin pasien harus diminta terlebih dahulu. Tenaga kesehatan perlu memahami dan mendukung perasaan keluarga.

f. *S - Devise a supportive Solution* (Menyusun solusi yang mendukung)

Tenaga kesehatan dapat menyusun solusi untuk mencapai kesepakatan terkait menyampaikan berita buruk dengan menentukan apakah komunikasi dalam menyampaikan berita buruk dilakukan oleh tenaga kesehatan atau keluarga dengan dukungan dokter. Tenaga kesehatan perlu menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan jika keluarga bersikeras untuk tidak menyampaikan berita buruk kepada pasien atau bertentangan dengan penilaian tenaga kesehatan. Dalam hal ini, pendekatan tenaga kesehatan akan bergantung pada konteks budaya dan hukum di setiap negara, seperti di Negara Inggris dimana keinginan pasien untuk mengetahui informasi tersebut lebih diutamakan daripada permintaan keluarga. setelah metode ARCHES dilakukan maka tenaga kesehatan dapat menyampaikan berita buruk kepada pasien dan keluarga menggunakan SPIKES.

L. Tujuan Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk

Tujuan utama dalam menyampaikan berita buruk yakni; (Kumar & Sarkhel, 2023)

1. Mengumpulkan informasi dari pasien guna memahami tingkat pemahaman pasien saat ini mengenai kondisinya serta apa saja harapannya.
2. Menyampaikan informasi dengan jelas sambil mempertimbangkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasien.
3. Memberikan dukungan dan bantuan psikologis yang tepat untuk menghadapi dampak dari kabar buruk tersebut
4. Meminimalkan rasa kesepian dan isolasi (meyakinkan bahwa pasien tidak ditinggalkan atau sendiri)
5. Menyusun rencana pengobatan dan strategi jangka panjang melalui kerja sama dengan pasien.

M.Siapa yang Seharusnya Menyampaikan Kabar Sulit atau Buruk

Penyampaian kabar buruk sebaiknya dilakukan oleh kepala unit atau seorang konsultan senior yang sudah dikenal oleh pasien dan keluarganya. Dalam keadaan darurat tertentu dimana konsultan yang menangani pasien sedang tidak berada di tempat, maka perawat senior dapat menyampaikan kabar buruk tersebut (Kumar & Sarkhel, 2023).

N. Faktor dalam Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk

Penyampaian kabar buruk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti (Kumar & Sarkhel, 2023)

1. Tenaga kesehatan tidak dapat memastikan respon atau reaksi emosional pasien dan keluarga, yang mungkin merasa takut atau tidak mampu menghadapi situasi tersebut, yang dapat menimbulkan reaksi emosional seperti terkejut, marah, sedih, penyangkalan, lega, atau menerima
2. Tenaga kesehatan tidak mengetahui apa yang diharapkan pasien
3. Tenaga kesehatan khawatir bahwa ia mungkin menghancurkan harapan pasien.
4. Kemampuan tenaga kesehatan mengelola reaksi emosional diri sendiri terhadap kabar buruk tersebut.
5. Tenaga kesehatan mungkin pernah memberikan gambaran yang terlalu optimis mengenai kondisi pasien di masa lalu, dan hal ini mungkin menimbulkan rasa malu dalam situasi saat ini di mana tenaga kesehatan harus menyampaikan kabar buruk.
6. Keterampilan humanistik, emosional, dan komunikasi tenaga kesehatan dalam menyampaikan berita buruk
7. Beban kerja yang tinggi dan rasio tenaga kesehatan terhadap pasien yang tidak memadai seringkali menyebabkan kurangnya waktu bagi tenaga kesehatan untuk mengenal peserta secara mendalam, yang terkadang membuat tenaga kesehatan ragu dalam memulai mendiskusikan berita buruk
8. Tidak adanya informasi terkait diagnosis atau prognosis akan memengaruhi cara pasien menerima kabar buruk dan mengurangi kecenderungan pasien untuk terlibat dalam diskusi.
9. Kesulitan dalam menerima prognosis yang buruk dan memahami batasan serta kompleksitas perawatan suportif,
10. Tujuan perawatan yang bertentangan antara anggota keluarga atau tim multidisiplin,
11. Keengganan untuk menerima kabar buruk karena keinginan untuk mempertahankan harapan akan kesembuhan
12. Minimnya fasilitas seperti ruang pribadi untuk berkomunikasi

O. Upaya dalam Penyampaian Kabar Sulit atau Buruk

Berikut beberapa hal yang dapat digunakan agar dapat menyampaikan berita buruk dengan lebih baik, seperti; (Moura et al., 2024)

1. Pelatihan keterampilan komunikasi terkait "*breaking bad news*" (penyampaian kabar buruk);

2. Menentukan intervensi keperawatan yang sensitif terhadap aspek agama dan budaya;
3. Menentukan intervensi keperawatan yang dapat menumbuhkan harapan dan mempertahankan keyakinan;
4. Pelatihan manajemen emosi;
5. Pelatihan untuk membina hubungan terapeutik;
6. Penerapan protokol atau model pedoman menyampaikan kabar buruk seperti SPIKES, ABCDE, BREAKS, PENS;
7. Modul yang memuat struktur komunikasi yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengungkapkan kebenaran, menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, serta mengumpulkan informasi yang rumit dengan penuh kehati-hatian, kepekaan, dan empati
8. Menghormati otonomi, kebutuhan, dan preferensi pasien dan keluarga.

P. Do dan Don'ts dalam Menyampaikan Kabar Sulit atau Buruk

Do dan Don'ts dalam menyampaikan berita buruk (Kumar & Sarkhel, 2023)

1. Do yang perlu diperhatikan atau dilakukan dalam menyampaikan berita buruk
 - a. Berikan ruang untuk keheningan serta reaksi emosional
 - b. Berikan waktu
 - c. Peka terhadap bahasa nonverbal
 - d. Catat dan berkoordinasi dengan tim multidisiplin
 - e. Gunakan bahasa yang sederhana dan berkomunikasi dengan jujur
 - f. Pastikan privasi dan kerahasiaan
 - g. Dengarkan apa yang dikatakan pasien
2. Don'ts yang perlu diperhatikan atau dilakukan dalam menyampaikan berita buruk
 - a. Berasumsi bahwa Anda tahu apa yang menjadi kekhawatiran pasien
 - b. Membuat komentar atau menyampaikan kalimat yang menghakimi
 - c. Memutarbalikkan fakta
 - d. Terus-menerus berbicara
 - e. Memberikan jaminan palsu
 - f. Memberikan informasi secara berlebihan
 - g. Menyembunyikan informasi

Q. Penutup

Perawatan paliatif diberikan sebagai upaya dalam membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga khususnya saat pasien berada pada fase akhir hidup sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan berbagai cara seperti *advance care planning* dan penyampaian kabar buruk "*breaking bad news*".

Pelaksanaan *advance care planning* dan penyampaian kabar buruk "*breaking bad news*" harus dilakukan dengan sangat baik melalui persiapan dan pemilihan metode yang baik agar harapan dan keinginan pasien dapat terjamin sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup pasien pada fase akhir hayat.

Referensi

- Ayalew, E. A., Mphuthi, D. D., & Matlhaba, K. L. (2023). Patients' preferences for delivering bad news in palliative care in Ethiopia: a qualitative study. *BMC Palliative Care*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12904-023-01275-5>
- Aydin, O. A., Bastarcan, Ç., & Aysegul, Y. K. (2020). Breaking Bad News in Palliative Care: Literature Review. *Folia Palliatica*, 1, 19–29. <https://www.capc.org/about/pallia->
- Goswami. (2021). Advance Care Planning and End-Of-Life Communications: Practical Tips for Oncology Advanced Practitioners. *Journal of the Advanced Practitioner in Oncology*, 12(1). <https://doi.org/10.6004/jadpro.2021.12.1.7>
- Harding, M. M., Kwong, J., Hagler, D., & Reinisch, C. (2023). Lewis's Medical-Surgical Nursing. In *Lewis's Medical-Surgical Nursing Assessment And Management Of Clinical Problems* (12th ed.). Elsevier Inc.
- Holmes, S. N., & Illing, J. (2021). Breaking bad news: Tackling cultural dilemmas. *BMJ Supportive and Palliative Care*, 11(2), 128–132. <https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2020-002700>
- Ibrahim, A. M., Zaghamir, D. E. F., Abdel-Aziz, H. R., Elalem, O. M., Al-yafeai, T. M., Sultan, H. M. S., Sliman, A. M. A., Elsaid, R. A. A., Aboelola, T. H., & Mersal, F. A. (2024). Ethical issues in palliative care: nursing and quality of life. *BMC Nursing*, 854(23).
- Kriekemans, L., Cavolo, A., Casaer, M., & Gastmans, C. (2025). Telehealth in palliative care settings: A systematic review of argument-based ethics literature. In *Palliative Medicine*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1177/02692163251360115>
- Kumar, V., & Sarkhel, S. (2023). Clinical Practice Guidelines on Breaking Bad News. *Indian J Psychiatry*, 2(65), 238–244. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_498_22
- Lee, Y. J., Kim, S.-H., Yoo, S. H., Kim, A.-S., Lin, C.-P., Martina, D., Mori, M., & Suh, S.-Y. (2024). Advance Care Planning in Palliative Care in Asia: Barriers and Implications. *Journal of Hospice and Palliative Care*, 27(4), 107–119. <https://doi.org/10.14475/jhpc.2024.27.4.107>
- Mailankody, S., Sherigar, P., Pai, A., Shenoy, R., Udupa, K., Lewis, S., & Rao, S. R. (2023). PENS approach for breaking bad news in the oncology outpatient setting: a real-

world report. *Supportive Care in Cancer*, 31(1). <https://doi.org/10.1007/s00520-022-07458-9>

Mursid, A., Haerianti, M., Harli, K., & Evidamayanti, E. (2024). Prinsip-Prinsip Komunikasi dalam Perawatan Paliatif dan Akhir Kehidupan. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 1(15), 28–33. <https://doi.org/10.33846/sf15105>

Schofield, G., Dittborn, M., Huxtable, R., Brangan, E., & Selman, L. E. (2021). Real-world ethics in palliative care: A systematic review of the ethical challenges reported by specialist palliative care practitioners in their clinical practice | Enhanced Reader. *Palliative Medicine*, 35(2).

Traboulsi, E. I. , Virginia Miraldi Utz, & Arif O. Khan. (2025). Genetic disease of the eye (3rd ed.). Oxford Monographs on Medical Genetics. https://doi.org/10.1093/med/9780197659403.0https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1LwEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA34&dq=breaking+bad+news+in+palliative+care+&ots=EWI-bVs-Mu&sig=Jd-uO9IBVk1kItxBzbfVt2CWr4U&redir_esc=y#v=onepage&q=breaking%20bad%20news%20in%20palliative%20care&f=false01.0001

BAB IV

DUKUNGAN KELUARGA DAN BEREAVEMENT CARE (EDUKASI CAREGIVER, DUKUNGAN PSIKOSOSIAL, PENDAMPINGAN DUKA, DAN RUJUKAN)

A. Pendahuluan

Seorang manusia berawal dari keluarga, keluarga merupakan akar sebuah kehidupan. Karakter seseorang terbentuk dari keluarga, karakter baik maupun karakter buruk. Lingkungan awal berasal dari keluarga, karena asal dari kehidupan seseorang dari keluarga. Budaya dan perilaku sehat berawal dari keluarga yang sehat dan damai serta sejahtera hati dan finansial. Pendidikan, tata karma, serta kehidupan bersosialisasi di masyarakat berawal dari keluarga yang lebih dini ditanamkan. Oleh sebab itu, kehidupan dalam keluarga berperan besar dalam unit pelayanan kesehatan karena masalah kesehatan merupakan masalah yang cukup krusial dalam mempengaruhi antar anggota keluarga dan masyarakat disekitarnya.

Bereavement artinya **duka cita, masa berkabung**, atau **kehilangan** seseorang yang dicintai karena kematian. Ini merujuk pada periode atau keadaan emosional/fisik yang dialami setelah kehilangan tersebut. Yang merupakan kondisi fisik seseorang yang mampu terjadi selama hidup. Masa ini sangat susah dilewati oleh seseorang karena kehilangan anggota keluarga yang dicintai memberikan kenangan yang bermakna apalagi jika itu adalah pasangan, anak, atau orangtua.

B. Konsep dasar Keluarga dan Dukungan Keluarga dalam Perawatan

Keluarga merupakan salah satu elemen terkecil masyarakat. Keberadaan keluarga di masyarakat akan menentukan perkembangan masyarakat (Stanhope & Lancaster, 1996). Keluarga menjadi tempat sentral bagi pertumbuhan dan perkembangan individu, sehingga keluarga menjadi salah satu aspek terpenting dari keperawatan. Keluarga bersama dengan individu, kelompok dan komunitas adalah klien atau resipien keperawatan (Friedman et al., 2003). Keluarga secara empiris, disadari bahwa kesehatan para anggota keluarga dan kualitas kesehatan keluarga mempunyai hubungan yang erat (Isnaini et al., 2020). Keberadaan keluarga yang dinamis di lingkungan komunitas tersebut memerlukan pengawasan dan fasilitasi yang baik dari aspek kesehatan. Ketidaktahuan, ketidakmauan, dan

ketidakmampuan keluarga dalam memfasilitasi tugas perkembangan dan melaksanakan tugas kesehatan keluarga akan mengakibatkan keluarga mengalami keadaan maladaptif dalam mencapai kemandirian keluarga (Isnaini et al., 2020). Hal ini memerlukan suatu fasilitas dari perawat keluarga dalam mengoptimalkan keluarga dalam mencapai tugas perkembangan dan kemandirian keluarga. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga juga merupakan suatu sistem. Keluarga merupakan sistem terbuka sehingga dapat dipengaruhi oleh supra sistemnya, yaitu lingkungannya (masyarakat), dan sebaliknya sebagai sub sistem dari lingkungan (masyarakat) keluarga dapat mempengaruhi masyarakat (suprasistem). Oleh karena itu betapa pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang sehat bio-psiko-sosial-spiritual. Jadi bila keluarga sebagai titik sentral pelayanan keperawatan, maka keluarga yang sehat akan mewujudkan generasi Emas 2045.

Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dan keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut

1. **Ayah** sebagai suami dari istri dan ayah bagi anak – anak, berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya.
2. **Ibu** sebagai istri dan ibu dari anak – anaknya, ibu mempunyai peranan untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik bagi anak – anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungannya, disamping itu juga ibu berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya
3. **Anak-anak**, melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.
(Suharti, dkk. 2024)

Dukungan keluarga merupakan komponen penting dalam keberhasilan perawatan pasien, terutama pada kondisi kronis, terminal, maupun paliatif. Keterlibatan keluarga terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien serta mempercepat proses adaptasi terhadap penyakit (Friedman, Bowden, & Jones, 2014; Nursalam et al., 2019). Dalam konteks Indonesia, dukungan keluarga memiliki peran yang sangat dominan karena sistem sosial yang masih berbasis kekeluargaan (Setyowati & Murti, 2018).

Dukungan keluarga mencakup aspek emosional, instrumental, informasional, dan spiritual. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan emosional dan spiritual memiliki pengaruh signifikan terhadap ketenangan pasien dalam menghadapi penyakit kronis (Sari & Wahyuni, 2020). Selain itu, dukungan keluarga juga terbukti meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan (Hidayati et al., 2021).

Efektivitas dukungan keluarga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta nilai budaya yang dianut (Kaakinen et al., 2015; Rahmawati & Dewi, 2020). Oleh karena itu, pendekatan berbasis keluarga menjadi sangat relevan dalam praktik pelayanan kesehatan di Indonesia.

Contoh Kasus Klinis:

Seorang pasien laki-laki usia 65 tahun dengan gagal jantung kronis dirawat di rumah. Istrinya berperan sebagai caregiver utama. Ia secara rutin membantu pemberian obat, menyiapkan makanan rendah garam, serta memberikan dukungan emosional saat pasien merasa sesak dan cemas. Anak-anak pasien yang tinggal di luar kota memberikan dukungan finansial dan komunikasi rutin melalui telepon.

Analisis:

Kasus ini menunjukkan kombinasi dukungan emosional, instrumental, dan informasional. Keterlibatan keluarga secara menyeluruh berkontribusi pada stabilitas kondisi pasien dan meningkatkan kualitas hidupnya.

C. Konsep dan Peran Caregiver

Menurut World Health Organization, caregiver merupakan bagian penting dari sistem perawatan jangka panjang yang membantu individu mempertahankan kualitas hidup dan kemandirian. Sementara itu, yang bertindak sebagai caregiver adalah anggota keluarga yang selalu mendampingi pasien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang memberikan perawatan tanpa dibayar kepada individu dengan kondisi kronis atau disabilitas. Caregiver memiliki peran penting dalam memberikan perawatan langsung kepada pasien. Di Indonesia, caregiver umumnya berasal dari anggota keluarga yang belum memiliki latar belakang kesehatan, sehingga edukasi menjadi kebutuhan utama (Nursalam, 2017).

Caregiver merupakan bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan modern, terutama dalam konteks perawatan jangka panjang, penyakit kronis, dan kondisi terminal. Caregiver secara umum dipahami sebagai individu yang memberikan bantuan, perawatan, dan dukungan kepada seseorang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri secara mandiri, baik karena faktor usia, penyakit, maupun disabilitas. Caregiver dapat berasal dari kalangan profesional (formal), seperti tenaga kesehatan, maupun dari keluarga (informal), yang sering kali menjadi

sumber utama perawatan sehari-hari. Definisi ini menegaskan bahwa caregiver bukan sekadar “pendamping”, melainkan bagian integral dari sistem perawatan yang berperan langsung dalam menjaga kualitas hidup pasien .

Dalam perspektif konseptual, caregiver tidak hanya menjalankan fungsi fisik seperti membantu aktivitas sehari-hari (makan, mandi, mobilisasi), tetapi juga memiliki dimensi psikologis, sosial, dan bahkan spiritual. Peran ini menjadi semakin kompleks ketika caregiver harus menghadapi kondisi pasien yang kronis atau progresif, seperti demensia, kanker, atau gangguan mental. Dalam situasi tersebut, caregiver tidak hanya memberikan bantuan praktis, tetapi juga menjadi sumber dukungan emosional utama bagi pasien. Hal ini terlihat dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan caregiver berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan perawatan dan stabilitas kondisi pasien, termasuk dalam pengelolaan penyakit kronis seperti hipertensi dan gangguan mental.

Secara deskriptif, peran caregiver dapat dipahami sebagai suatu proses relasional yang melibatkan interaksi intens antara caregiver dan individu yang dirawat. Hubungan ini sering kali dibangun atas dasar kedekatan emosional, terutama pada caregiver keluarga, sehingga menimbulkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, peran ini dapat memberikan makna dan kepuasan batin karena adanya rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Namun di sisi lain, caregiver juga rentan mengalami tekanan fisik, emosional, dan sosial yang dikenal sebagai *caregiver burden*. Kondisi ini mencerminkan kelelahan multidimensional yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional akibat tuntutan perawatan yang terus-menerus .

Lebih lanjut, konsep caregiver juga erat kaitannya dengan kemampuan coping dan adaptasi. Dalam praktiknya, caregiver sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan, kurangnya dukungan sosial, serta konflik peran antara tanggung jawab merawat dan kehidupan pribadi. Penelitian fenomenologi menunjukkan bahwa caregiver dapat mengalami dampak psikososial yang signifikan, termasuk stres, kelelahan, dan perubahan dalam kualitas hidup. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas caregiver melalui edukasi, pelatihan, dan dukungan psikososial menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan mereka mampu menjalankan perannya secara optimal.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, caregiver juga berperan sebagai mitra tenaga kesehatan. Mereka menjadi penghubung antara pasien dan sistem layanan, membantu dalam pengambilan keputusan, pemantauan kondisi pasien, serta pelaksanaan intervensi yang direkomendasikan. Peran ini menempatkan caregiver sebagai bagian dari tim multidisiplin yang berkontribusi terhadap keberhasilan terapi dan peningkatan kualitas hidup pasien. Bahkan dalam beberapa studi, disebutkan bahwa efektivitas perawatan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana

caregiver mampu menjalankan perannya secara aktif dan terinformasi. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa caregiver juga merupakan individu yang memiliki kebutuhan dan keterbatasan. Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas perawatan yang diberikan. Oleh karena itu, pendekatan yang berpusat pada caregiver (*caregiver-centered care*) mulai dikembangkan, yang menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan caregiver sebagai bagian dari sistem perawatan yang berkelanjutan.

Keluarga dalam pandangan perspektif sistem merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi (Maglaya, 2009). Sehingga, keluarga menjadi salah satu pemegang peran dalam melakukan perawatan pada anggota keluarga. Memahami peran keluarga sebagai caregiver, memerlukan pemahaman tentang fungsi keluarga dan struktur di dalam keluarga (Titin, caecilia.dkk, 2024). Keluarga sebagai caregiver memiliki kewenangan dalam memutuskan permasalahan dengan benar, terutama pada anggota keluarga yang mengalami ketergantungan. Dalam memutuskan masalah kesehatan dan hal yang akan dilakukan memerlukan adanya pemahaman dampak positif dan negatif dari perlakuan yang diputuskan. Sehingga perlu adanya identifikasi dan mengeksplor keluarga tentang apa yang perlu dilakukan jika anggota keluarga memiliki masalah kesehatan.

Peran keluarga sebagai caregiver yaitu,

1. Keluarga melakukan perawatan pada anggota keluarga yang sakit dengan benar
2. Keluarga dapat melakukan modifikasi lingkungan
3. Keluarga dapat menggunakan layanan kesehatan dengan tepat

Peran keluarga Sebagai caregiver, terdapat beragam peran seperti pada paparan penelitian, yaitu domain utama peran caregiver yaitu membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tugas perawatan mandiri, mobilisasi anggota keluarga yang sakit, memberikan dukungan emosional, membantu menjaga hubungan dengan sosial, memfasilitas fasilitas kesehatan, membantu dalam koordinasi dalam perawatan seperti berhubungan dengan dokter dan tenaga medis. Peran ini memiliki banyak aktivitas yang dilalui dan seorang caregiver penting untuk memiliki pengetahuan dalam hal mencari problem solving (pemecahan masalah), membuat keputusan (decision making), dan komunikasi (Schulz et al., 2020)

Peranan sebagai caregiver tidak luput dari pembinaan dan pemberian edukasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat pasien. Studi menunjukkan bahwa edukasi yang baik dapat meningkatkan kemampuan caregiver dalam melakukan perawatan mandiri di rumah serta menurunkan angka komplikasi (Wulandari et al., 2019). Materi edukasi meliputi

perawatan dasar, manajemen gejala, serta komunikasi efektif dengan pasien. Metode edukasi yang efektif di Indonesia antara lain melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas dan pendampingan langsung (Astuti & Kurniawan, 2021). Evaluasi berkala penting dilakukan untuk memastikan keberhasilan edukasi (Bastawrous, 2013).

D. Dukungan Psikososial bagi Keluarga dan Caregiver

Beban psikologis yang dialami caregiver menjadi isu penting dalam perawatan jangka panjang. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa caregiver pasien kronis memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, terutama akibat beban perawatan dan keterbatasan dukungan sosial (Fitriani et al., 2020). Dukungan psikososial bertujuan membantu caregiver dalam mengelola stres dan meningkatkan kemampuan coping. Strategi coping yang adaptif, seperti dukungan sosial dan pendekatan religius, terbukti efektif dalam konteks budaya Indonesia (Yusuf et al., 2017). Dukungan psikososial adalah bentuk intervensi yang mengintegrasikan aspek psikologis (emosi, kognisi, perilaku) dan sosial (hubungan interpersonal, dukungan lingkungan) untuk membantu individu menghadapi tekanan hidup, terutama dalam konteks penyakit kronis dan perawatan jangka panjang.

Dalam konteks caregiving, dukungan psikososial bertujuan untuk:

1. Mengurangi stres dan beban caregiver

Upaya untuk menurunkan tekanan fisik, emosional, mental, dan sosial yang dialami oleh seorang caregiver (orang yang merawat individu yang sakit, lansia, atau membutuhkan bantuan). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

a. Stres caregiver

Caregiver sering menghadapi kelelahan, kecemasan, atau tekanan emosional karena tanggung jawab merawat yang terus-menerus. Mengurangi stres berarti membantu mereka merasa lebih tenang, tidak mudah lelah secara mental, dan mampu mengelola emosi dengan lebih baik.

b. Beban fisik

Aktivitas seperti mengangkat pasien, membantu aktivitas sehari-hari, atau berjaga dalam waktu lama bisa melelahkan tubuh. Pengurangan beban berarti meringankan tugas-tugas tersebut, misalnya dengan bantuan orang lain atau alat bantu.

c. Beban psikologis

Caregiver bisa merasa sedih, khawatir, atau bahkan burnout. Mengurangi beban ini berarti memberikan dukungan seperti konseling, edukasi, atau waktu istirahat.

d. **Beban sosial dan ekonomi**

Peran sebagai caregiver kadang membatasi waktu untuk bekerja atau bersosialisasi. Mengurangi beban berarti membantu mereka tetap memiliki keseimbangan antara merawat, bekerja, dan kehidupan pribadi.

2. Meningkatkan kemampuan koping

Upaya untuk memperkuat kemampuan seseorang dalam menghadapi, mengelola, dan beradaptasi terhadap stres, tekanan, atau masalah yang dialami. Koping (coping) adalah cara atau strategi yang digunakan individu untuk mengatasi situasi sulit, baik secara emosional maupun praktis. Membantu seseorang agar lebih mampu menghadapi, menyesuaikan diri, dan mengatasi situasi yang sulit atau menekan. Beberapa contoh kemampuan yang dapat dilakukan yaitu, mengelola stres saat merawat orang yang sakit atau membutuhkan bantuan, mengendalikan emosi seperti cemas, sedih, marah, atau lelah, mencari solusi ketika menghadapi masalah perawatan, tetap berfungsi dengan baik meskipun berada dalam tekanan, menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak mudah.

3. Menjaga kesejahteraan mental dan sosial

Memastikan seseorang tetap sehat secara psikologis (pikiran dan emosi) serta tetap memiliki hubungan sosial yang baik dan bermakna dengan orang lain, meskipun berada dalam situasi yang menantang seperti menjadi caregiver. Kesejahteraan mental mengacu pada kondisi di mana seseorang mampu:

- a. **Mengelola emosi** dengan baik (tidak mudah cemas, marah, atau putus asa)
- b. **Memiliki pikiran yang positif dan realistis**
- c. **Mampu menghadapi tekanan** tanpa mengalami gangguan seperti burnout atau depresi
- d. **Merasa memiliki kontrol diri** dan tujuan hidup

Pada caregiver, menjaga kesejahteraan mental berarti tetap stabil secara emosional walaupun menghadapi tuntutan merawat yang berat.

Kesejahteraan sosial mengacu pada kemampuan untuk, menjalin dan mempertahankan hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan. Mendapatkan dukungan sosial (emosional, informasi, maupun bantuan praktis). Tetap berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Tidak merasa terisolasi atau kesepian. Hal ini penting bagi caregiver karena peran merawat sering membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosial.

Caregiver sering menghadapi tekanan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan, sehingga membutuhkan intervensi yang komprehensif. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan melalui komunikasi terapeutik dan konseling. Pendekatan family-centered care juga

terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis caregiver (Davidson et al., 2007; Prasetyo & Handayani, 2022).

Contoh Kasus Klinis:

Seorang caregiver yang merawat pasien stroke mengalami kelelahan fisik dan stres emosional. Ia mulai merasa putus asa dan menarik diri dari lingkungan sosial. Setelah mendapatkan konseling dan bergabung dengan kelompok dukungan caregiver, kondisi psikologisnya membaik dan ia mampu melanjutkan perawatan dengan lebih baik.

Analisis:

Dukungan psikososial membantu caregiver mengelola stres dan meningkatkan coping mechanism sehingga mencegah burnout.

E. Konsep dan Tahapan Bereavement (Kedukaan)

Bereavement merupakan respons alami terhadap kehilangan. Dalam konteks budaya Indonesia, proses berduka seringkali dipengaruhi oleh nilai religius dan tradisi lokal (Rahayu & Widodo, 2019).

Model tahapan kedukaan yang dikemukakan oleh Kübler-Ross tetap relevan, namun penelitian lokal menunjukkan bahwa individu di Indonesia cenderung lebih mengandalkan pendekatan spiritual dalam menghadapi kehilangan (Kübler-Ross, 1969; Suryani et al., 2021).

Faktor yang memengaruhi proses berduka meliputi hubungan emosional dengan almarhum, dukungan sosial, serta keyakinan agama. Duka komplikasi perlu diwaspadai karena dapat berdampak pada kesehatan mental individu (Worden, 2009; Lestari et al., 2020).

Mengutip dari *Healthline*, pada tahun 1969, seorang psikiater bernama Elizabeth Kübler-Ross menulis dalam bukunya *On Death and Dying* bahwa kesedihan dapat dibagi menjadi lima tahap atau *stages of grief*. Seperti diketahui, kesedihan atau duka itu wajar terjadi. Penyebabnya pun beragam, seperti kematian orang yang dicintai, mengakhiri hubungan, kehilangan pekerjaan, atau perubahan lain yang mengubah hidup. Jadi, manusia wajar jika menangis, marah, menarik diri, atau bahkan merasa hidup sudah tidak ada artinya lagi. Setiap orang memproses kesedihan secara berbeda, tetapi ada beberapa kesamaan dalam tahapan perasaan yang dialami selama bersedih. Berikut adalah fase-fase Emosi dalam Berduka:

1. Penolakan (*Denial*)

Sering terjadi ketika orang menanggapi perasaan yang menyakitkan dengan berpura-pura baik-baik saja atau tidak terjadi apa pun, itulah penolakan. Fase menolak emosi ini memberimu waktu untuk menyerap kesedihan secara bertahap dan mulai memprosesnya. Penolakan adalah mekanisme pertahanan yang umum dilakukan. Tapi, jika terus menyangkal akan menyulitkan hidupmu.

2. Kemarahan (Anger)

Seperti bom waktu, efek dari penolakan dan menyembunyikan perasaan terus-menerus dapat memicu amarah. Kemarahan ini dapat diarahkan pada orang lain, seperti orang yang meninggal, mantan, atasan, dan bahkan benda mati. Namun, saat kemarahan mereda, kamu akan mulai berpikir lebih rasional tentang apa yang terjadi dan merasakan emosi yang telah lama disembunyikan.

3. Tawar Menawar (Bargaining)

Selama kesedihan, tidak jarang seseorang mencari cara untuk mendapatkan kendali atau ingin merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi hasil suatu peristiwa. Pada tahap tawar-menawar, kamu akan mendapati dirimu sering memikirkan kemungkinan dengan 'seandainya', 'bagaimana jika', atau 'jika saja'. Tawar-menawar adalah garis pertahanan melawan emosi kesedihan, yang membantumu menunda kesedihan, kebingungan, atau sakit hati.

4. Depresi (Depression)

Pada titik ini, depresi bukanlah tanda kondisi kesehatan mental. Sebaliknya, itu adalah respons alami dan tepat untuk kesedihan. Selama tahap depresi, kamu mulai menghadapi kenyataan saat ini dan kesedihan yang dialami. Kesadaran akan akar masalah yang dihadapi mungkin membuatmu putus asa secara mendalam, tapi inilah langkah yang harus dilewati untuk bangkit.

5. Penerimaan (Acceptance)

Penerimaan belum tentu merupakan tahap kesedihan yang membahagiakan atau membangkitkan semangat. Itu tidak berarti kamu telah melewati kesedihan. Namun, untuk memastikan bahwa kamu telah menerimanya dan telah memahami apa artinya dalam hidupmu sekarang. Kamu akan merasa sangat berbeda dalam tahap ini. Selain itu, di fase ini Kawan pun akan menyadari bahwa dirimu sudah mengalami perubahan besar dalam hidup.

Contoh Kasus Klinis

Seorang wanita kehilangan suaminya akibat penyakit kanker. Pada awalnya ia menyangkal kenyataan tersebut, kemudian menunjukkan kemarahan dan kesedihan mendalam. Setelah beberapa bulan, ia mulai menerima kehilangan dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Analisis:

Kasus ini mencerminkan proses berduka yang normal sesuai tahapan, meskipun tidak selalu linear.

Kasus ini menunjukkan proses berduka yang relatif adaptif dan progresif, di mana individu mampu bergerak melalui berbagai respons emosional hingga mencapai tahap penerimaan. Jika dianalisis secara konseptual, pengalaman yang dialami wanita tersebut selaras dengan model tahapan berduka yang diperkenalkan

oleh Elisabeth Kübler-Ross, yang meliputi penyangkalan (*denial*), kemarahan (*anger*), kesedihan/depresi (*depression*), dan akhirnya penerimaan (*acceptance*). Pada fase awal, penyangkalan yang muncul merupakan mekanisme pertahanan psikologis yang wajar. Individu berusaha melindungi dirinya dari beban emosional yang terlalu berat akibat kehilangan pasangan hidup. Fase ini biasanya bersifat sementara dan membantu memberikan waktu bagi individu untuk menyesuaikan diri secara bertahap terhadap realitas baru.

Selanjutnya, munculnya kemarahan mencerminkan reaksi emosional terhadap rasa ketidakadilan atau kehilangan kontrol. Kemarahan ini dapat diarahkan pada berbagai pihak, termasuk kondisi penyakit, tenaga kesehatan, bahkan diri sendiri. Bersamaan dengan itu, kesedihan mendalam menjadi indikator bahwa individu mulai menyadari sepenuhnya makna kehilangan tersebut. Pada tahap ini, risiko gangguan psikologis seperti depresi atau isolasi sosial dapat meningkat, sehingga dukungan keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan. Perkembangan positif terlihat ketika, setelah beberapa bulan, individu mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Penerimaan dalam konteks ini bukan berarti tidak lagi merasakan kehilangan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mengintegrasikan pengalaman duka ke dalam kehidupan sehari-hari. Kembalinya aktivitas rutin menunjukkan adanya proses adaptasi yang sehat, di mana individu mampu membangun kembali fungsi sosial dan emosionalnya.

Dari perspektif *bereavement care*, kasus ini dapat dikategorikan sebagai duka normal (*normal grief*), bukan duka komplikasi (*complicated grief*), karena terdapat pergerakan yang jelas menuju pemulihan tanpa hambatan berkepanjangan. Namun demikian, tetap penting dilakukan pemantauan, terutama dalam beberapa bulan pertama setelah kehilangan, untuk memastikan tidak terjadi perburukan kondisi psikologis.

Implikasi praktis dari kasus ini menekankan pentingnya:

1. Dukungan emosional yang konsisten dari keluarga dan lingkungan sekitar
2. Komunikasi empatik dari tenaga kesehatan
3. Pemberian ruang bagi individu untuk mengekspresikan duka tanpa penilaian
4. Intervensi profesional (misalnya konseling) jika respons berduka menjadi berkepanjangan atau mengganggu fungsi sehari-hari

Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan bahwa proses berduka adalah pengalaman yang dinamis dan sangat individual, namun dengan dukungan yang tepat, individu memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya secara bermakna.

F. Bereavement Care (Pendampingan Duka)

Bereavement care adalah rangkaian dukungan yang diberikan kepada individu atau keluarga yang mengalami kehilangan (kematian orang yang dicintai), dengan tujuan membantu mereka melewati proses berduka secara sehat, adaptif, dan bermakna. Pendekatan komprehensif yang membantu individu menghadapi kehilangan secara sehat tidak hanya mengurangi kesedihan, tetapi juga membantu mereka menemukan makna, beradaptasi, dan melanjutkan kehidupan dengan lebih kuat. Pendampingan duka merupakan intervensi penting untuk membantu individu melalui proses kehilangan secara sehat. Di Indonesia, pendekatan berbasis spiritual dan komunitas memiliki peran besar dalam proses ini (Kellehear, 2012; Hapsari et al., 2021).

Bereavement care merupakan suatu bentuk pelayanan yang berfokus pada pendampingan individu atau keluarga yang mengalami kehilangan akibat kematian orang yang dicintai. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada fase setelah kematian, tetapi juga mencakup periode sebelum kematian (*anticipatory grief*), saat kematian terjadi, hingga masa penyesuaian setelah kehilangan. Dalam praktiknya, bereavement care menjadi bagian integral dari *Palliative Care*, yang menekankan pentingnya kualitas hidup tidak hanya bagi pasien, tetapi juga bagi keluarga yang ditinggalkan.

Ketika seseorang menghadapi kehilangan, respons emosional yang muncul sering kali sangat kompleks dan mendalam. Individu dapat merasakan kesedihan yang intens, kehampaan, kecemasan, bahkan perasaan bersalah. Proses ini dikenal sebagai *grief* atau berduka, yang secara klasik dijelaskan oleh Elisabeth Kübler-Ross melalui tahapan penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Meskipun model ini memberikan gambaran umum, para ahli menekankan bahwa proses berduka bersifat sangat individual dan tidak selalu berlangsung secara linier. Setiap orang memiliki cara unik dalam memahami dan merespons kehilangan, yang dipengaruhi oleh faktor seperti kedekatan hubungan dengan almarhum, kondisi psikologis sebelumnya, serta dukungan sosial yang tersedia (Stroebe, Schut, & Boerner, 2017).

Dalam konteks ini, bereavement care hadir sebagai bentuk dukungan yang komprehensif dan berkesinambungan. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan empatik, di mana tenaga kesehatan, *caregiver*, maupun keluarga berperan sebagai pendengar yang aktif tanpa memberikan penilaian. Individu diberikan ruang untuk mengekspresikan emosi secara terbuka, sehingga mereka dapat memproses kehilangan secara lebih sehat. Selain itu, intervensi psikologis seperti konseling juga sering digunakan untuk membantu individu mengelola stres,

kecemasan, dan potensi gangguan mental yang dapat muncul setelah kehilangan (Worden, 2018).

Aspek sosial dalam bereavement care juga memiliki peranan yang sangat penting. Kehilangan sering kali membuat seseorang merasa terisolasi dan terputus dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, teman, maupun kelompok dukungan (support group) menjadi faktor protektif yang signifikan dalam proses adaptasi. Interaksi sosial yang positif dapat membantu individu merasa dipahami, diterima, dan tidak sendirian dalam menghadapi duka (Parkes & Prigerson, 2013). Di samping itu, dimensi spiritual juga tidak dapat diabaikan, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai religius yang kuat. Banyak individu menemukan makna dan kekuatan melalui keyakinan spiritual, yang membantu mereka menerima kenyataan kehilangan dan melanjutkan kehidupan dengan perspektif baru.

Meskipun demikian, tidak semua individu mampu melewati proses berduka dengan baik. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat mengalami apa yang disebut sebagai prolonged grief disorder atau duka berkepanjangan, yang ditandai dengan kesedihan yang intens dan menetap dalam jangka waktu lama hingga mengganggu fungsi sehari-hari. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan intervensi profesional, karena dapat berkembang menjadi gangguan mental yang lebih serius seperti depresi atau kecemasan kronis (American Psychiatric Association, 2022).

Secara keseluruhan, bereavement care bertujuan untuk membantu individu beradaptasi dengan kehilangan yang dialami, bukan untuk menghilangkan rasa duka itu sendiri. Kehilangan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, namun dengan dukungan yang tepat, individu dapat belajar untuk menerima realitas tersebut, menemukan makna di balik pengalaman yang menyakitkan, dan melanjutkan kehidupan dengan cara yang lebih sehat dan bermakna. Dengan demikian, bereavement care tidak hanya berfungsi sebagai bentuk intervensi, tetapi juga sebagai proses penyembuhan yang berkelanjutan.

Pendampingan dapat dimulai sejak fase anticipatory grief hingga pasca kehilangan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan tenaga kesehatan yang empatik dapat mengurangi risiko duka komplikasi (Ferrell & Coyle, 2015; Putri & Safitri, 2022). Teknik komunikasi empatik, seperti mendengarkan aktif dan validasi emosi, menjadi kunci dalam pendampingan. Selain itu, dukungan berbasis budaya dan agama perlu diintegrasikan dalam praktik pelayanan.

G. Rujukan dan Sistem Dukungan Lanjutan

Rujukan dan sistem dukungan lanjutan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada konteks perawatan jangka panjang, paliatif, dan dukungan psikososial seperti dalam bereavement care. Konsep ini merujuk pada proses pengalihan tanggung jawab pelayanan dari satu penyedia layanan ke penyedia lain yang lebih kompeten atau lebih sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga, serta keberlanjutan dukungan yang diberikan setelah intervensi awal selesai. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kesinambungan perhatian terhadap kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual individu. Rujukan biasanya dilakukan ketika kebutuhan pasien atau keluarga telah melampaui kapasitas layanan primer. Misalnya, seorang caregiver atau anggota keluarga yang mengalami tekanan emosional berat setelah kehilangan mungkin memerlukan intervensi lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Dalam hal ini, tenaga kesehatan berperan sebagai penghubung yang memastikan individu tersebut mendapatkan layanan yang tepat, baik di tingkat spesialis maupun komunitas. Sistem rujukan yang efektif harus didasarkan pada komunikasi yang jelas, koordinasi antarprofesi, serta pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan pasien. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Palliative Care yang menekankan pendekatan holistik dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan.

Selain rujukan formal, sistem dukungan lanjutan juga mencakup berbagai bentuk bantuan yang berkelanjutan setelah fase akut atau krisis terlewati. Dukungan ini dapat berasal dari keluarga, komunitas, kelompok sebaya (support group), maupun lembaga sosial dan keagamaan. Kehadiran sistem dukungan yang kuat memungkinkan individu untuk tetap merasa terhubung, dipahami, dan didampingi dalam proses adaptasi terhadap perubahan hidup yang signifikan, seperti kehilangan orang tercinta. Menurut John W. Worden, proses berduka yang sehat sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu untuk memperoleh dukungan sosial yang memadai, karena hal ini membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas berduka secara adaptif. Dalam konteks layanan kesehatan modern, sistem dukungan lanjutan juga mencakup layanan berbasis komunitas dan home care, yang memungkinkan individu mendapatkan pendampingan tanpa harus selalu berada di fasilitas kesehatan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan karena memberikan fleksibilitas dan kenyamanan, serta memperkuat peran keluarga sebagai bagian dari sistem perawatan. Selain itu, integrasi antara layanan kesehatan formal dan sumber daya komunitas terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup serta menurunkan risiko komplikasi psikologis, seperti depresi dan isolasi sosial (Stroebe, Schut, & Boerner, 2017).

Namun demikian, efektivitas rujukan dan sistem dukungan lanjutan sangat bergantung pada aksesibilitas layanan, kesiapan sumber daya, serta sensitivitas budaya dalam pemberian dukungan. Di banyak konteks, hambatan seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, atau stigma terhadap layanan kesehatan mental dapat menghambat individu untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat jejaring layanan, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap dukungan yang berkelanjutan. Rujukan dan sistem dukungan lanjutan bukan sekadar mekanisme teknis dalam pelayanan kesehatan, melainkan suatu proses berkelanjutan yang memastikan bahwa individu tidak dibiarkan menghadapi tantangan hidup sendirian. Dengan adanya koordinasi yang baik antar layanan dan dukungan sosial yang kuat, individu dapat menjalani proses pemulihan, adaptasi, dan pencarian makna hidup dengan lebih optimal.

Sistem rujukan menjadi penting ketika keluarga membutuhkan bantuan profesional lebih lanjut. Di Indonesia, rujukan biasanya melibatkan psikolog, psikiater, serta tenaga kesejahteraan sosial (WHO, 2018; Kemenkes RI, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa sistem rujukan yang terintegrasi dapat meningkatkan akses layanan kesehatan mental dan kualitas hidup caregiver (Sutrisno et al., 2021). Kolaborasi multidisiplin sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan yang komprehensif. Pemantauan dan tindak lanjut menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan dukungan bagi keluarga.

H. Tantangan dan Strategi Implementasi di Lapangan

Pelaksanaan dukungan keluarga dan bereavement care di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, rendahnya literasi kesehatan, serta stigma terhadap gangguan mental (Kemenkes RI, 2020; Widiastuti et al., 2019). Tantangan dan strategi implementasi dukungan keluarga serta bereavement care di lapangan merupakan isu yang kompleks karena melibatkan interaksi antara aspek medis, psikologis, sosial, budaya, dan sistem layanan kesehatan. Dalam praktiknya, penerapan konsep ini tidak selalu berjalan ideal, terutama ketika dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, perbedaan pemahaman, serta dinamika keluarga yang beragam. Secara deskriptif, salah satu tantangan utama dalam implementasi dukungan keluarga adalah keterbatasan pengetahuan dan kesiapan keluarga dalam memberikan perawatan dan dukungan emosional. Banyak keluarga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bagaimana merawat anggota keluarga yang sakit atau menghadapi proses berduka. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga sering kali mengalami kebingungan dalam

mengenali masalah, mengambil keputusan, serta memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan dukungan yang diberikan menjadi tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus dapat memperburuk kondisi psikologis pasien maupun anggota keluarga lainnya.

Selain itu, tantangan lain yang sering muncul adalah beban emosional dan psikologis pada keluarga dan caregiver. Kehilangan atau menghadapi anggota keluarga yang sakit kronis dapat memicu stres, kecemasan, dan kelelahan emosional yang berkepanjangan. Dalam konteks bereavement care, individu yang berduka tidak hanya membutuhkan waktu untuk memproses kehilangan, tetapi juga memerlukan lingkungan yang suportif. Namun, pada kenyataannya, tidak semua keluarga mampu memberikan dukungan tersebut karena mereka sendiri juga berada dalam kondisi berduka. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa kehilangan dapat memunculkan berbagai reaksi emosional seperti kebingungan, kemarahan, dan kesedihan yang mendalam, sehingga membutuhkan pendampingan yang terstruktur.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, pembicaraan mengenai kematian dan proses berduka masih dianggap sebagai hal yang sensitif atau bahkan tabu. Stigma terhadap layanan kesehatan mental juga menjadi hambatan tersendiri, sehingga individu yang membutuhkan bantuan profesional sering kali enggan untuk mencari pertolongan. Kurangnya komunikasi terbuka dalam keluarga juga dapat memperburuk kondisi ini, menyebabkan individu merasa terisolasi dalam menghadapi kehilangan. Bahkan dalam konteks perawatan, keluarga terkadang belum optimal dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari dukungan holistik.

Di sisi lain, tantangan implementasi juga muncul dari sistem layanan kesehatan itu sendiri, seperti keterbatasan tenaga profesional yang terlatih dalam bereavement care, kurangnya integrasi antar layanan, serta minimnya program tindak lanjut (follow-up) setelah kematian pasien. Padahal, dukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti prolonged grief atau gangguan psikologis lainnya. Tanpa sistem rujukan dan dukungan lanjutan yang baik, individu yang berduka berisiko tidak mendapatkan intervensi yang tepat waktu. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan kontekstual. Salah satu strategi utama adalah peningkatan edukasi dan kapasitas keluarga. Keluarga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam merawat pasien serta memahami proses berduka, sehingga mereka dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Edukasi ini dapat dilakukan melalui tenaga kesehatan, program komunitas, maupun media edukatif yang mudah

diakses. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan khusus dalam bereavement care juga menjadi langkah penting, karena tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan yang empatik dan profesional.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah penguatan dukungan sosial berbasis komunitas. Keterlibatan masyarakat, kelompok dukungan (support group), serta tokoh agama atau budaya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi individu yang berduka. Dukungan sosial terbukti memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dan mempertahankan kesejahteraan emosional. Dalam hal ini, keluarga tidak menjadi satu-satunya sumber dukungan, tetapi menjadi bagian dari jaringan dukungan yang lebih luas. Selain itu, integrasi layanan kesehatan dengan pendekatan multidisiplin juga menjadi strategi kunci. Kolaborasi antara dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga spiritual memungkinkan pemberian layanan yang lebih holistik dan berkesinambungan. Sistem rujukan yang jelas dan efektif perlu dikembangkan agar individu yang membutuhkan bantuan lanjutan dapat segera mendapatkan layanan yang sesuai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam Palliative Care yang menekankan pentingnya koordinasi lintas profesi dalam memberikan perawatan yang komprehensif.

Pada akhirnya, implementasi dukungan keluarga dan bereavement care di lapangan memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem yang lebih luas, termasuk keluarga, komunitas, dan layanan kesehatan. Dengan mengatasi berbagai tantangan melalui strategi yang tepat, diharapkan individu yang mengalami kehilangan dapat menjalani proses berduka secara lebih sehat, adaptif, dan bermakna.

Perbedaan budaya dan kepercayaan juga memengaruhi penerimaan intervensi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal menjadi strategi yang efektif (Kellehear, 2012; Rahman et al., 2021). Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan serta penguatan jejaring layanan menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pendekatan komunitas mampu meningkatkan efektivitas dukungan keluarga (Nurhidayah et al., 2022).

I. Penutup

Dukungan keluarga dan *bereavement care* merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kesehatan yang berorientasi pada manusia secara holistik. Dalam konteks penyakit kronis, terminal, maupun situasi kehilangan, keluarga bukan hanya berperan sebagai pendamping pasien, tetapi juga sebagai

bagian yang terdampak secara langsung baik secara emosional, psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, intervensi yang menysasar keluarga menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas hidup pasien tetap optimal serta proses berduka yang dialami keluarga dapat berlangsung secara adaptif. Dukungan keluarga tidak hanya berbentuk bantuan fisik, tetapi juga mencakup komunikasi yang empatik, kehadiran emosional, serta kemampuan memahami kebutuhan pasien secara komprehensif. Di sisi lain, *bereavement care* hadir sebagai pendekatan yang sistematis dalam membantu individu maupun keluarga menghadapi kehilangan, mulai dari fase anticipatory grief hingga tahap pemulihan pasca-kehilangan. Proses ini membutuhkan sensitivitas budaya, pendekatan multidisiplin, serta kesinambungan layanan agar dapat berjalan efektif

Tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, serta stigma terhadap kesehatan mental, menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang berpihak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Integrasi antara layanan medis, psikososial, dan spiritual menjadi kunci dalam menciptakan sistem dukungan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya memperkuat dukungan keluarga dan pelayanan *bereavement care* bukan sekadar bagian dari praktik profesional, tetapi juga merupakan wujud nyata dari kepedulian kemanusiaan yang mendalam.

Referensi

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). Washington, DC: APA Publishing.
- Astuti, R., & Kurniawan, A. (2021). Edukasi caregiver dalam perawatan pasien kronis di rumah. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(2), 85–92.
- Fitriani, D., Sari, Y., & Rahman, A. (2020). Beban psikologis caregiver pasien penyakit kronis. *Jurnal Ners*, 15(1), 45–52.
- Hapsari, D., Nugroho, A., & Putra, B. (2021). Pendampingan duka berbasis spiritual di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 10(2), 101–110.
- Hidayati, N., Lestari, S., & Dewi, R. (2021). Dukungan keluarga dan kepatuhan pengobatan pasien kronis. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 16(1), 12–18.
- Isnaini, A. F., Susanto, T., Susumaningrung, L. A., Rasni, H., & Siswayo, S. (2020). Hubungan fungsi keluarga dengan status gizi balita pada keluarga tiri di

- kecamatan panti kabupaten jember. *Jurnal Ilmu Keperawatan Komunitas*, 3(1), 1–10.
- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman pelayanan paliatif di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kustanti, C. Y., et al. (2025). Peningkatan kapasitas perawat dalam memberikan bereavement care melalui pendekatan empatik. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*.
- Lestari, P., Wulandari, D., & Sari, M. (2020). Duka komplikasi pada keluarga pasien. *Jurnal Kesehatan Mental Indonesia*, 9(1), 33–40.
- Nurhidayah, I., Pratiwi, A., & Sulastri, E. (2022). Pendekatan komunitas dalam perawatan paliatif. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 7(2), 67–75.
- Nursalam, N., Efendi, F., & Dian, P. (2019). Family support and patient outcomes. *Jurnal Ners*, 14(3), 123–130.
- Nursalam. (2017). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Parkes, C. M., & Prigerson, H. G. (2013). *Bereavement: Studies of Grief in Adult Life* (4th ed.). London: Routledge.
- Prasetyo, Y., & Handayani, S. (2022). Family-centered care dalam meningkatkan kesejahteraan caregiver. *Jurnal Keperawatan Klinis*, 5(1), 21–28.
- Putri, A., & Safitri, D. (2022). Peran tenaga kesehatan dalam pendampingan duka. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 10(1), 55–62.
- Rahayu, S., & Widodo, T. (2019). Budaya dan proses berduka di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 17(2), 120–128.
- Rahman, F., Yusuf, A., & Hidayah, N. (2021). Pendekatan budaya dalam perawatan kesehatan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 16(1), 1–8.
- Rahmawati, D., & Dewi, L. (2020). Faktor yang memengaruhi dukungan keluarga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 89–96.
- Retnaningsih, D., Khoirunnisa, V. A., & Rohana, N. (2020). Dukungan keluarga terhadap perawatan palliative pada pasien Ca mammae. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*.
- Sari, M., & Wahyuni, E. (2020). Dukungan spiritual pada pasien kronis. *Jurnal Keperawatan Holistik*, 4(1), 23–30.

- Setyowati, S., & Murti, B. (2018). Peran keluarga dalam perawatan pasien. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 12(3), 150–156.
- Stroebe, M., Schut, H., & Boerner, K. (2017). Models of coping with bereavement: An updated overview. *Studies in Psychology*, 59(2), 1–16.
- Suharti, Sri & dkk , (2024) . Keperawatan Keluarga (Teori dan Implementasi). Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia
- Suryani, L., Dewi, R., & Prasetyo, A. (2021). Mekanisme coping spiritual dalam menghadapi kehilangan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 18(1), 44–52.
- Sutrisno, E., Hadi, S., & Putra, R. (2021). Sistem rujukan kesehatan mental di Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 134–142.
- Titin, caecilian, dkk (2024) . Keluarga sebagai caregiver dan masalah kesehatan Lansia. Jakarta barat : Nuansa Fajar Cemerlang
- Utama, T. A., & Yanti, L. R. D. (2020). Dukungan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di ruang ICU. *Jurnal Vokasi Keperawatan*.
- Widiastuti, N., Sari, D., & Lestari, R. (2019). Stigma kesehatan mental di masyarakat. *Jurnal Kesehatan Jiwa*, 7(2), 75–82.
- Worden, J. W. (2018). *Grief Counseling and Grief Therapy: A Handbook for the Mental Health Practitioner* (5th ed.). New York: Springer Publishing Company.
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2020). *Integrating palliative care and symptom relief into primary health care: A WHO guide for planners, implementers and managers*. Geneva: WHO.
- Wulandari, D., Fitri, H., & Sari, N. (2019). Pengaruh edukasi caregiver terhadap kemampuan perawatan. *Jurnal Ners*, 14(2), 98–104.
- Yusuf, A., Fitryasari, R., & Nihayati, H. (2017). *Keperawatan kesehatan jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.

PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan

Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa: Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Keperawatan, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh PT. Optimal untuk Negeri, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendikristek (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*



Siti Rachmah, S.KM., M.Kes. lahir di Surabaya, pada 17 Agustus 1964. Menyelesaikan pendidikan Akademi Keperawatan (Program Keguruan) di Akper Sutopo Surabaya, S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya dan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini penulis sebagai Staf Dosen di Program Studi S1 Keperawatan dan Ners di Stikes Majapahit Mojokerto.



Masyita Haerianti, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Sidodadi, 21 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2007 dan Profesi Ners, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2017. Penulis berstatus sebagai dosen tetap pada Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2018 hingga sekarang dan mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Paliatif dan Konsep Dasar Keperawatan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: masyitahaerianti@unsulbar.ac.id

Motto: "let's do it to complete it "



Nadia Alfira, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Kabupaten Bulukumba. 8 Juni 1989. Riwayat Pendidikan, lulus di SDN 179 Tanahberu dan SDN 155 Centre Tanahberu, SMPN 1 Bontobahari dan SMAN 1 Bontobahari. Tahun 2011 lulus S1 Keperawatan dan Profesi Ners 2013 di UIN Alauddin Makassar, Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Keperawatan UNHAS Makasar lulus tahun 2017. Dosen pengajar S1 Keperawatan di STIKES Panrita Husada Bulukumba Tahun 2014 sampai sekarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa/Keperawatan medical bedah, keperawatan kegawatdaruratan, Falsafah dan teori Keperawatan. Penulis aktif

dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: karuajune9891@gmail.com

Motto: Ikhtiar, Berdoa, dan tawakkal. InsyaALLAH ada jalan.

Sinopsis

Buku referensi Keperawatan Paliatif: Asuhan Komprehensif, Kontrol Gejala, dan Dukungan Keluarga pada Penyakit Mengancam Nyawa membahas konsep dan praktik asuhan keperawatan paliatif bagi pasien dengan penyakit yang mengancam nyawa. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan yang holistik, humanis, dan berpusat pada pasien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarganya.

Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip dasar keperawatan paliatif, pengkajian kebutuhan pasien, manajemen nyeri, kontrol gejala, komunikasi terapeutik, dukungan psikologis, sosial, dan spiritual, serta keterlibatan keluarga dalam proses perawatan. Buku ini juga menjelaskan peran perawat sebagai pemberi asuhan, pendamping, edukator, dan advokat bagi pasien.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, dan tenaga kesehatan lainnya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam memberikan asuhan paliatif yang profesional, empatik, bermartabat, serta berorientasi pada kenyamanan dan kualitas hidup pasien.

Buku referensi Keperawatan Paliatif: Asuhan Komprehensif, Kontrol Gejala, dan Dukungan Keluarga pada Penyakit Mengancam Nyawa membahas konsep dan praktik asuhan keperawatan paliatif bagi pasien dengan penyakit yang mengancam nyawa. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan yang holistik, humanis, dan berpusat pada pasien untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarganya.

Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip dasar keperawatan paliatif, pengkajian kebutuhan pasien, manajemen nyeri, kontrol gejala, komunikasi terapeutik, dukungan psikologis, sosial, dan spiritual, serta keterlibatan keluarga dalam proses perawatan. Buku ini juga menjelaskan peran perawat sebagai pemberi asuhan, pendamping, edukator, dan advokat bagi pasien.

Dengan penyajian yang sistematis dan mudah dipahami, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat praktisi, dan tenaga kesehatan lainnya. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam memberikan asuhan paliatif yang profesional, empatik, bermartabat, serta berorientasi pada kenyamanan dan kualitas hidup pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-03-9 (PDF)



9

786347

756039

